

北京市医疗机构创新药品配备及使用模式研究

2025年11月



清华大学药学院
School of Pharmaceutical Sciences, Tsinghua University

目录

前言	1
一、创新药品配备及使用模式现状	1
（一）北京市推动创新药临床使用的特色举措.....	1
1. 国家医保谈判药品直接纳入全市定点医疗机构药品目录.....	1
2. 创新药“双通道”管理优化、扩围保供应.....	2
3. 创新药 DRG 以外单独支付、单独核算.....	2
（二）北京市创新药进入公立医院使用的程序及模式.....	3
1. 常规程序和特殊程序（进院流程）	3
2. 创新药续约期后进院模式.....	3
3. “双通道”模式（基本医保）	4
4. 临时采购模式（基本医保等）	4
5. 特殊病房配备模式（商业保险、国际部）	4
（三）上海市支持创新药发展的若干措施.....	5
1. 鼓励创新产品入院配备使用.....	5
2. 加大创新产品医保支付支持力度.....	5
3. 支持创新产品示范应用与推广.....	5
（四）四川省支持创新药临床应用的措施.....	5
（五）海南省支持创新药械发展的措施.....	6
二、北京市公立医疗机构创新药配备及使用情况	7
（一）创新药毛配备率为 65.8%，谈判成功创新药毛配备率为 87.9%.....	8
（二）创新药使用金额 23.7 亿，仅占公立医院药品使用金额的 1.5%.....	8
（三）创新药 94.5%在三级医院使用，金额为 22.4 亿.....	10
（四）创新药使用量偏低，仅为全部药品使用量的 0.1%.....	10
（五）三级公立医院创新药品使用量占各级医院总使用量的 68.1%.....	11
（六）创新药品总平均进院率为 3.0%，谈判药品为 14.0%.....	12
（七）非医保创新药的平均单价显著高于医保创新药平均单价.....	13
（八）抗肿瘤创新药使用金额最高，心血管系统创新药使用量最高.....	14

(九) 使用金额前十名的创新药主要为化学药品, 抗肿瘤药 7 种.....	14
(十) 38 个创新药无使用数据.....	15
三、影响创新药在北京市医疗机构配备的原因	17
(一) 医疗机构对创新药安全性和有效性的顾虑.....	17
(二) 谈判药品落地政策和用药管理考核政策的协同性不足.....	17
(三) 财务和管理成本影响部分医疗机构配备主动性.....	19
(四) 临时采购入院比例较低, 路径受限.....	19
四、影响创新药通过双通道模式配备使用的原因	20
(一) 双通道药品目录覆盖仅关注当年国谈创新药.....	20
(二) 电子处方开具和流转管理存在滞后.....	20
(三) 外配药品费用纳入医保总额可能影响药品可及.....	21
(四) “双通道” 配套报销保障政策不足.....	21
(五) 双通道药店药事服务能力与医院相比有差距.....	21
(六) 双通道可能变成单通道影响创新药进医院.....	22
五、完善北京市医疗机构创新药配备及使用模式的政策建议	23
(一) 细化政策措施, 明确创新药进院的路径和方式.....	23
(二) 督促医疗机构及时召开针对国谈药品的药事会.....	23
(三) 将创新药准入和配备使用纳入医疗机构考评体系.....	24
(四) 优化创新药品准入和使用考核.....	24
(五) 加强医保部门、卫生健康部门和药监部门协同.....	25
(六) 提高医疗机构对支持创新药发展相关政策的认识.....	25
(七) 完善“双通道” 政策管理.....	25
附录:	27
一、术语解释	27
二、2021-2023 年北京市公立医院药品使用数据分析表格汇总 ...	28
(一) 各级公立医院各类药品用量、金额、平均进院率数据统计.....	28
1. 药品、医保药、非医保药数据统计表.....	28

2. 谈判药品数据统计表.....	29
3. 创新药数据统计表.....	30
4. 各治疗领域创新药数据统计表.....	32
(二) 公立医院使用金额前十的各类药品分析表.....	33
1. 使用金额前十的谈判药品分析表.....	33
2. 使用金额前十的创新药品分析表.....	37
三、《北京市医疗机构创新药品配备及使用模式研究》调研报告	39
(一) 调研背景.....	39
(二) 创新药企业调研情况反馈.....	39
1. 医疗机构配备创新药品现状.....	39
2. 通过国家医保谈判 / 竞价准入新药在医疗机构的配备现状.....	39
3. 国谈新药进院的主要障碍.....	39
4. 自费创新药品进院困难.....	40
5. “双通道” 药店途径配备的现状和问题.....	40
6. 创新药品企业的政策建议.....	41
(三) 医疗机构调研情况反馈.....	42
1. 北京市医疗机构配备创新药品的途径.....	42
2. 北京市医疗机构配备创新药品的现状.....	43
3. 北京市医疗机构配备创新药品的考虑、障碍及困难.....	43
4. 医疗机构做临时采购的考量.....	46
5. 其他方面的困难与建议.....	47
(四) 调研结论与建议.....	48
1. 主要结论.....	48
2. 系统性建议.....	48

前言

为贯彻落实党中央、国务院关于全链条支持创新药发展的决策部署，切实满足人民群众多元化就医用药需求，2025 年 6 月，国家医保局 国家卫生健康委联合制定发布《支持创新药高质量发展的若干措施》。该文件提出支持创新药进入“双目录”，一方面健全基本医保药品目录动态调整机制，立足基金承受能力与临床需求，定期调整优化医保目录，按程序纳入符合条件的创新药；特殊公共卫生事件急需创新药，可研究临时纳入支付范围。另一方面增设商业健康保险创新药品目录。同时，文件从简化挂网流程、加速入院配备、提升使用能力、优化支付管理等环节，全方位支持创新药的临床应用。

2025 年 4 月，北京市医疗保障局等九部门已联合印发《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2025 年）》（简称《北京若干措施 2025》），进一步细化支持创新药临床应用的措施，加速北京市医药健康产业创新，推动创新药、创新医疗器械高质量发展，助力发展新质生产力，更好地满足人民群众防病治病需求。

为全面了解创新药品在北京市医疗机构的配备使用情况，本研究基于北京市医药卫生科技促进中心提供的 2021-2023 年公立医院药品使用数据（源自北京市卫健委），综合运用 python 语言编程与 Visual Studio Code 工具，对创新药的配备使用特征进行量化分析。课题组通过多维度调研方法，组织 10 家国内创新药企业和跨国药企召开座谈会，开展在线问卷调查并回收了 13 家代表性企业的调研问卷，进行详细分析。同时，遴选了六家三级医院药学和临床专家开展咨询，并对位于北京的三家三级医院开展实地调研，确保研究数据的全面性与实证基础的可信度。

一、创新药品配备及使用模式现状

（一）北京市推动创新药临床使用的特色举措

1. 国家医保谈判药品直接纳入全市定点医疗机构药品目录

国谈药强制进院。明确国家医保谈判药品直接纳入全市定点医疗机构药品目录，医疗机构可通过“双通道”药店实现“应开尽开”，不得以“一品两规”“药占比”等限制配备（《北京若干措施 2025》第十八条）。

创新药获批上市后，鼓励 1 类创新药 1 个月内快速挂网，在京医疗机构率先使用，备案后不计入基本医保自费率指标（《北京若干措施 2025》第十九条）。

提前介入医保准入沟通。创新药企向药监部门提交新药上市申请后，可同步与医保、卫健部门沟通，提前规划医保准入和入院使用方案，包括主规格、支付范围等关键问题（《北京若干措施 2025》第十九条）。

2. 创新药“双通道”管理优化、扩围保供应

优化药店布局与管理。全市三级医院全面实施“双通道”，协议药店覆盖所有区：核心区（东城、西城等）从已试点药店中指定 1 家，郊区（门头沟、延庆等）在三级医院周边遴选 1 家全区共用药店，签订“医疗机构 - 药店 - 医保”三方协议（2024 年试点基础上，《北京若干措施 2025》第十八条延续并强化）。

降低药店连锁门店面积标准并取消总部持股比例限制，支持药品批发企业构建多仓协同物流模式，保障药品供应（《北京若干措施 2025》第十八条）。

3. 创新药 DRG 以外单独支付、单独核算

创新药单独支付政策。对符合条件的创新药，不计入 DRG 病组支付标准，单独核算，减轻医院医保控费压力。（《北京若干措施 2025》第十九、二十条）。

优化医院采购与结算。推动医保基金与药企直接结算创新药、集采药品费用，探索医保基金向药企提前预付，缓解医院垫资压力（《北京若干措施 2025》第二十二条）。

真实世界研究支持。对临床数据不足但创新价值高的药物，医院通过真实世界研究验证价值后，可获资金支持，并作为医保准入参考（《北京若干措施 2025》第十九条）。

表 1-1 北京市推动创新药临床使用的特色举措

维度	北京特色举措	落实国家政策方向
谈判药品进院	国谈药直接进医院目录，1 类新药 1 个月内快速挂网	加速创新药临床可及性
双通道管理	全市覆盖、取消药店连锁限制、多仓物流保障	提升药品供应效率与公平性
便利医院使用	单独支付、医保预付、真实世界研究激励	降低医院使用创新药的制度性成本

（二）北京市创新药进入公立医院使用的程序及模式

1. 常规程序和特殊程序（进院流程）

北京市创新药进入公立医院包括常规程序和特殊程序两种模式。

常规程序流程：常规程序包括申请、评审、审批、采购、使用五个环节。临床科室提出创新药引进申请，提交药品的临床价值评估、循证医学证据和预期使用情况。药学部门进行初步审查，包括药理学特性评估、注册信息核实、药物经济学评价和同类药品对比分析。

药事管理委员会从安全性、有效性、经济性和必要性四个维度进行评估。安全性评估包括不良反应谱、禁忌症和药物相互作用；有效性评估包括临床疗效和适应症覆盖；经济性评估包括成本效益比和医保支付情况；必要性评估包括临床需求程度和替代药品情况。评审通过后，提交院长办公会或医院党委会审批。

政策规定取消医疗机构药品数量限制。对于国谈药品，《北京若干措施 2024》要求目录公布后一个月内召开药事会，全年药事会召开不少于 4 次《北京若干措施 2025》进一步简化程序，明确规定国谈药直接纳入定点医疗机构药品目录。采购通过北京市药品阳光采购平台进行。

特殊程序机制：特殊程序包括三种类型。绿色通道适用于临床急需且国内无同类产品、罕见病用药、突发公共卫生事件急需药品和国家鼓励的重大创新药品。绿色通道简化审批环节，缩短评审时间，允许先使用后补审。

临时采购程序适用于紧急医疗需求。触发条件包括患者生命危急、现有药品治疗无效、医生明确推荐使用且患者同意承担费用。审批权限为科主任推荐、药学部门审核、医务处批准、院领导签字。使用管理限定范围和时间，监测不良反应，定期评估使用效果。

专家会诊程序适用于争议较大、价格昂贵、涉及伦理问题或跨学科使用的创新药品。程序包括邀请院外专家、多学科联合评议、循证医学论证和风险效益评估。

2. 创新药续约期后进院模式

药事会决策滞后。续约创新药需重新提交材料，企业需重复应对不同医院的评审标准。如成都某药企反映，省级医院与市级医院对“创新价值”的定义差异导致材料修改 3 次。

品规限制“变相存在”。虽多地取消药品总数限制（如广东、北京），但医院通过“一品两规”“同类药品淘汰制”隐性控制进院药品数量。

医保控费压力传导。医院需承担药品储存、损耗成本（零加成下无利润），叠加 DRG/DIP 付费改革，使用高价续约药可能导致科室亏损。

3. “双通道”模式（基本医保）

根据《北京若干措施 2024》，北京市推进二级及以上定点医疗机构通过定点医疗机构和定点零售药店“双通道”保障国谈药供应。

双通道模式运行方式：患者可凭医生开具的外配处方，在定点医疗机构或定点零售药店购买所需药品。该模式将具备专业服务能力的院外特供药房（DTP 药房）纳入医保定点机构，患者在这些药房购买创新药品可享受与医院相同的医保报销待遇。

支付保障措施：基本医疗保险门诊特殊病种治疗中使用的国谈药品纳入门诊特病管理，提高报销比例；治疗费用较高的国谈药品实行按固定比例支付，减轻参保人员费用负担。

4. 临时采购模式（基本医保等）

临时采购模式主要针对临床急需但尚未纳入常规采购目录的创新药品。

临时采购的基本情况：当出现药品短缺或紧急需求时，北京市启动临时采购程序，通过开启短缺药品绿色通道，直接将所需药品纳入北京市药品阳光采购综合管理平台进行挂网采购。医疗机构可通过订购、首购等方式采购技术含量高、临床需求大的高端医疗器械和创新药品。

支持措施：采购创新医疗器械不纳入“耗占比”管理，完善 CHS-DRG 付费新药新技术除外支付等配套措施。对于涉及新医疗技术的创新医疗器械，符合条件的可随时申报新增医疗服务价格项目。

5. 特殊病房配备模式（商业保险、国际部）

北京市公立医院特殊病房（特需病房、国际部、VIP 部等）主要服务于自费患者和持有商业保险的患者。

服务模式特点：特殊病房设有独立门诊区域，提供温馨就诊环境和便捷服务流程。实行预约诊疗、分时段就诊和“一站式”综合服务，出诊医师均具有副高级以上职称。服务内容包括健康管理、预防接种、商业保险直付、24 小时急诊等特

色服务。

商业保险直付：部分医院的国际/特需医疗部已开通商业保险直付通道，患者在治疗期间可享受一站式结算服务，费用由医院与保险公司直接结算。试点医院被允许按照相关规定自主定价，充分发挥市场调节机制。

药品配备特点：由于选派经验丰富的医师出诊，使用先进检查设备，通常涵盖疑难病、罕见病的多学科诊疗（MDT）团队，其药品配备和收费标准普遍高于普通医疗服务。

（三）上海市支持创新药发展的若干措施

2024 年 7 月，上海市人民政府办公厅《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》（沪府办规〔2024〕9 号）对创新产品入院和医保支持提出三方面的意见：

1. 鼓励创新产品入院配备使用

持续更新“新优药械”产品目录，开通创新药械挂网“绿色通道”，推荐纳入国家医保药品或“沪惠保”等目录保障范围。在国家医保药品和“新优药械”产品更新发布 1 个月内，上海市医疗机构根据临床需求和医院特色，将相应创新药械以“应配尽配”原则配备使用。及时将符合条件的药店纳入“双通道”范围。加强对市级医院创新责任考核，医疗机构不得以用药数量、药/耗占比等原因限制创新药械入院。

2. 加大创新产品医保支付支持力度

对于国家医保谈判药品和创新医疗器械涉及的诊疗项目，实行医保预算单列支付、在 DRG/DIP 改革中单独支付；对符合条件的高价值创新医疗器械、创新医疗服务项目，在 DRG/DIP 改革中独立成组、提高支付标准、不受高倍率病例数限制。对符合规定的“新优药械”产品，及时研究纳入医保支付范围。

3. 支持创新产品示范应用与推广

支持医疗机构与企业合作开展创新药械应用示范项目，进行上市后评价、真实世界疗效评价、适应症拓展等研究，按照规定择优给予每个项目最高 200 万元支持。支持在生物医药领域开展政府采购合作创新。

（四）四川省支持创新药临床应用的措施

2025 年 3 月，四川省卫健委等五部门联合下发《关于推动支持创新药临床

应用的通知》（川卫药物食品函〔2025〕64号），在畅通创新药入院流程、强化创新药临床应用，打造创新药临床应用场景等九个方面做出政策安排。

其中，要求医疗机构在获悉创新药挂网信息后 1 个月内召开药事会，按照“按需配备、应配尽配”的原则，对讨论通过的品种在 2 个月内完成创新药采购入院。其次，医保部门对国谈创新药按单行支付双通道管理、DRG/DIP 除外机制、特例单议机制等，对病例费用超出按病种付费支付标准的，支持申请特例单议。此外，对考核及结算等方面也提出了具体措施。

（五）海南省支持创新药械发展的措施

2024 年 1 月，海南省医疗保障局、海南省卫生健康委、海南省药品监督管理局等八部门联合印发了《海南省支持创新药械发展的若干措施》（以下简称《措施》），提出 24 条措施确保创新药械通过审评审批后与医疗保障等制度有效衔接，促进“三医”联动和协同发展，加快通过审评审批创新药械上市使用，促进海南省医药产业创新发展。

《措施》提出，建立新批准创新药械进入市场的首发价格形成机制。同时优化新增医疗服务价格项目试行期医疗机构自主定价机制，备案后即可收费。除国家谈判药品和集中带量采购的药械外，鼓励医疗机构和创新药械企业在采购平台自主议价。

对具有临床突破性价值，治疗费用较高的创新药械和医疗技术，探索建立基于证据的有条件支付（CED）模式，支持和鼓励患者使用创新药械，用支付创新推动产业创新。

优化对创新药械采购的管理。对一类重大科技创新转化新药，以及国内首创或属于重大技术创新，诊断治疗罕见病、老年人多发疾病、专用于儿童、临床急需的，列入国家科技重大专项、重点研发计划或省级重大科研项目支持的医疗器械直接挂网采购，实行阳光挂网服务主动承诺，明确服务内容、操作路径、办结时限和咨询机制，提高服务效率，促进新产品迅速应用于临床。

优化审批时限方面，《措施》提出，对符合条件的创新药械，挂网申请 5 个工作日内完成，对优化重大疾病诊疗方案或填补诊疗空白的重大创新项目开辟绿色通道，在接到申请后 10 个工作日内完成审核并向国家医保局报告。

对接服务机制。对创新药、创新医疗器械等重点产品建立提前介入机制，对

企业申请创新药械挂网、医保编码赋码、申报纳入医保目录、参加国家医保药品谈判、申请新增医疗服务价格项目等工作，建立“医疗医药服务业务对外接待日”“面对面”对接服务机制，为企业提供常态化咨询服务，对本省创新药品纳入医保药品目录或参与医保药品谈判给予更多的扶持，解决工作中的重点和难点问题。

二、北京市公立医疗机构创新药配备及使用情况

根据北京市医药卫生科技促进中心提供的数据（2021-2023 年北京公立医院药品使用数据），本研究覆盖北京市 513 家公立医院，其中一级、二级和三级医院分别为 347 家（67.6%）、74 家（14.4%）和 92 家（17.9%）。

本研究聚焦于 2019 年至 2023 年间国家药品监督管理局批准的 111 个创新药（I 类化药和生物制品创新药）。药品医保属性依据数据库标识判定（标记“Y”为医保药品，空白或者“N”为非医保药品）。

研究数据库共涉及药品品种 4209 个，其中，医保目录药品 2534 个，创新药 73 个（含医保目录内创新药 47 个，医保目录外创新药 26 个）。谈判纳入医保目录的创新药为 51 个。另有 38 个创新药在研究期间无使用记录。

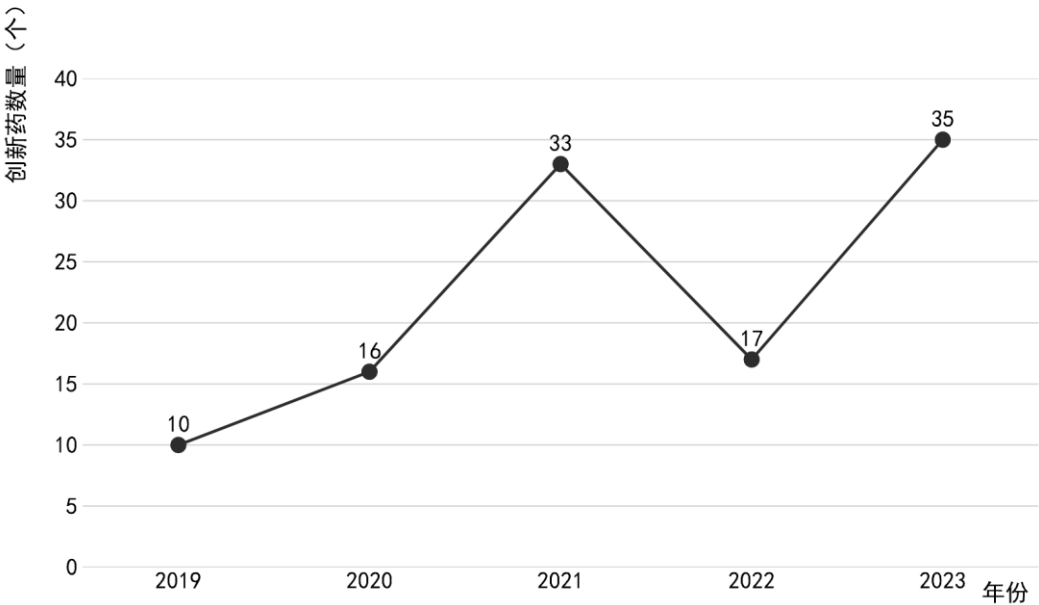


图 2-1 2019-2023 年国家药监局批准的创新药（I 类化药和生物制品）数量

表 2-1 2021 年-2023 年北京市公立医院使用的药品数量

年份	医保目录药品数量	谈判创新药数量	创新药数量	医保目录内创新药		医保目录外创新药	
				国产	进口	国产	进口
2021	2173	12	20	8	0	11	1
2022	2408	22	32	13	2	15	2
2023	2455	45	70	38	6	25	1
总计	2534	51	73	47		26	

注：表中纳入医保的创新药均以截至 2023 年底纳入医保情况为准。

（一）创新药毛配备率为 65.8%，谈判成功创新药毛配备率为 87.9%

2021-2023 年间，北京市公立医院有使用记录的创新药共 73 个（表 2-1）。数据显示，创新药（含医保和非医保）毛配备率为 65.8%；国家谈判成功创新药（简称谈判创新药）的配备率为 87.9%。按年度趋势来看，创新药毛配备率呈现稳步提升（图 2-2），印证了政策引导的积极效果。

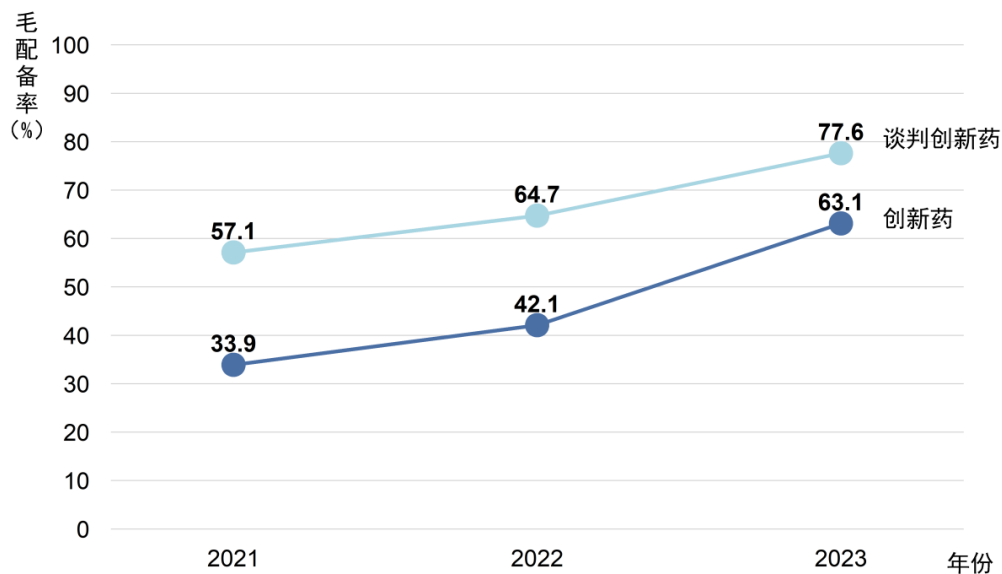


图 2-2 2021-2023 年北京市公立医院创新药配备情况

（二）创新药使用金额 23.7 亿，仅占公立医院药品使用金额的 1.5%

由表 2-2 可知，公立医院创新药使用金额逐年增加，但其临床渗透水平仍然有限，使用金额占比较低。三年累计使用金额 23.7 亿元，仅占公立医院使用药品总金额（1555.5 亿）的 1.5%。

从支付结构看，医保创新药使用金额达 16.7 亿元（其中谈判创新药为 16.4 亿元），与非医保创新药（7.0 亿），形成约 7:3 的支付格局（图 2-3）。同时，年度趋势分析显示，创新药及谈判药使用金额持续增长，而非医保创新药金额则

逐年下降（图 2-4），显示出医保覆盖在创新药临床使用中的主导作用。

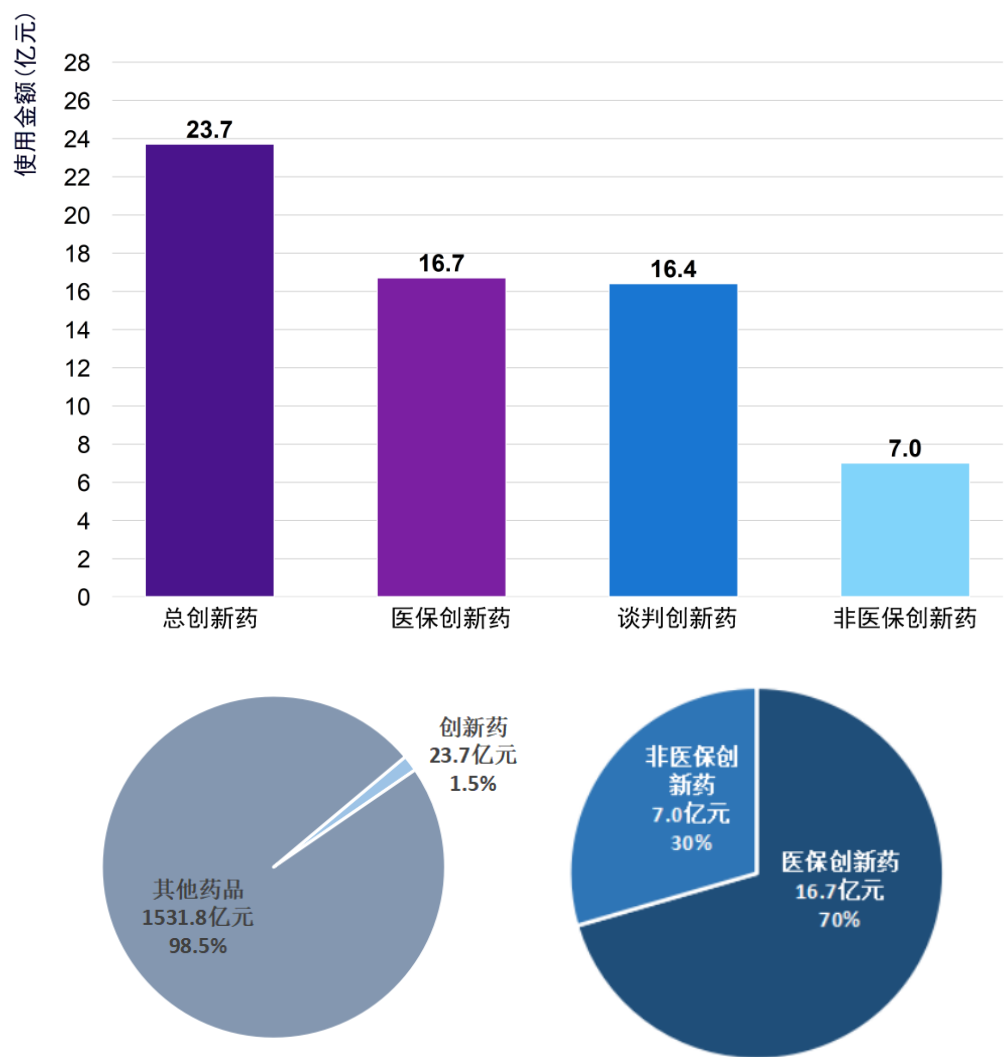


图 2-3 2021-2023 年创新药使用金额及占比

表 2-2 各级医院各类药品使用金额及占比

公立医院级别	使用总金额（亿）	医保药品金额（亿）	占比（%）	谈判药品金额（亿）	占比（%）	创新药金额（亿）	占比（%）
三级	1120.1	981.1	87.6	125.2	8.2	22.4	2.0
二级	132.6	120.6	91.0	5.3	4.0	1.1	0.8
一级	302.7	282.3	93.3	5.4	1.8	0.2	0.1
总计	1555.5	1384.1	89.0	135.9	8.7	23.7	1.5

表 2-3 各级医院创新药品使用金额及占比

公立医院级别	创新药金额(亿)	占比(%)	医保目录内创新药金额(亿)	占比(%)	谈判创新药金额(亿)	占比(%)	医保目录外创新药金额(亿)	占比(%)
三级	22.4	2.0	15.6	1.4	15.3	1.4	6.8	0.6
二级	1.1	0.8	0.9	0.7	0.9	0.7	0.2	0.2
一级	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
总计	23.7	1.5	16.7	1.1	16.4	1.1	7.0	0.5

注：总计占比均为该列药品金额对使用总金额的占比；三级行的占比均为该列药品金额对三级医院使用总金额的占比；二级与一级同理。

（三）创新药 94.5%在三级医院使用，金额为 22.4 亿

由表 2-3 可知，创新药使用呈现出高度集中于三级医院的结构性特征。数据显示，三级公立医院创新药使用金额为 22.4 亿元（占创新药总使用金额 94.5%，占三级医院使用金额的 2%），占据绝对主导地位；其金额构成为谈判创新药使用金额 15.4 亿元，非医保创新药使用金额 6.8 亿元。相比之下，二级和一级医院的创新药使用规模显著偏小，金额仅为 1.1 亿元、0.2 亿元。

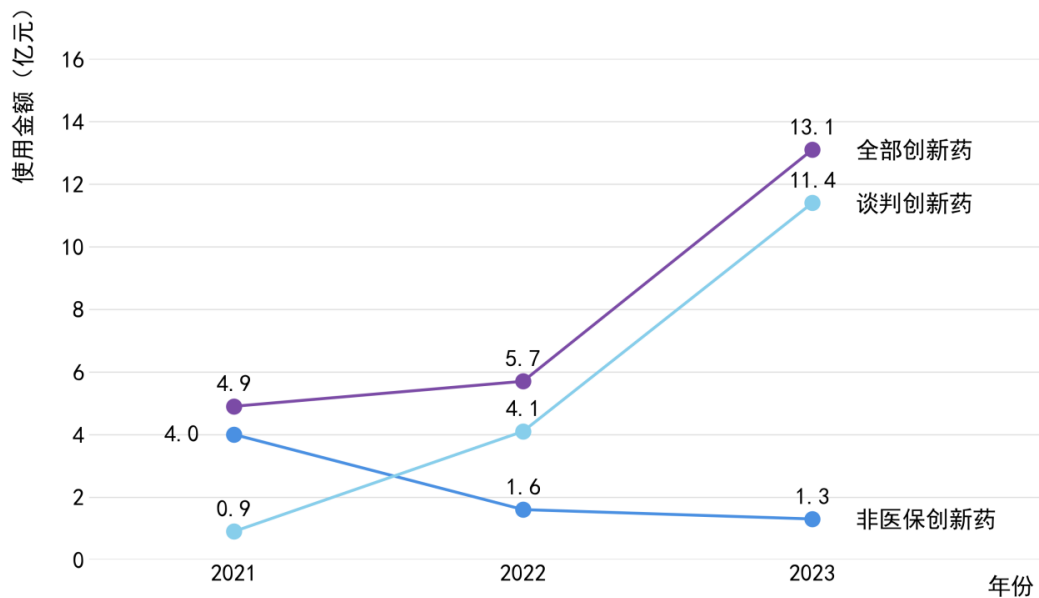


图 2-4 2021-2023 年创新药使用情况

（四）创新药使用量偏低，仅为全部药品使用量的 0.1%

由表 2-4 可知，2021-2023 年间，北京市公立医院创新药总使用量为 5781.4 万单位，仅占全部药品使用总量（572 亿单位）的 0.1%，表明其临床使用频次仍

处于较低水平。从构成看，使用量主要来自医保创新药（5194.4 万单位，其中，谈判创新药占 5032.6 万），非医保创新药使用量仅为 586.9 万单位。

值得注意的是，创新药年度使用量显著增长，从 2021 年的 271.9 万单位、2022 年的 1112.2 万快速提升至 2023 年的 4397.4 万单位，反映出其临床采纳速度正在加快。

（五）三级公立医院创新药品使用量占各级医院总使用量的 68.1%

由表 2-5、图 2-5 可知，创新药使用量在不同级别医院间呈现阶梯式分布。三级医院是绝对主力，使用量达 3936.8 万单位，占总量的 68.1%；其中，医保和谈判创新药用量分别为 3366.8 万（占比 58.2%）和 3205.2 万单位（占比 55.4%）；非医保创新药用量为 570.0 万单位。二级医院使用量为 1382.2 万单位（占比 23.9%），而一级医院使用量仅为 462.4 万单位（占比 8.0%）。

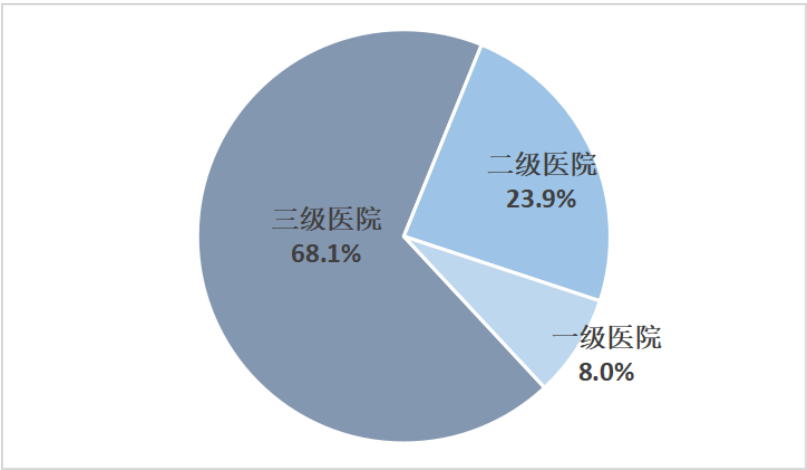


图 2-5 2021-2023 年创新药使用量各级医院占比

表 2-4 各级医院各类药品使用量统计及占比

医院级别	总使用量（亿）	医保药品（亿）	占比（%）	谈判药品（亿）	占比（%）	创新药品（亿）	占比（%）
三级	286.6	272.7	95.2	4.5	1.6	0.39	0.1
二级	61.1	58.1	95.1	0.5	0.8	0.14	0.2
一级	224.3	216.9	96.7	1.3	0.6	0.05	0.0
总计	572	547.7	95.6	6.4	1.5	0.58	0.1

表 2-5 各级医院创新药品使用量统计及占比

公立医院 级别	创新药 用量 (万)	占比 (%)	医保目录 内创新药 用量 (万)	占比 (%)	谈判创 新药用 量 (万)	占比 (%)	医保目录 外创新药 用量 (万)	占比 (%)
三级	3936.8	0.14	3366.8	0.12	3205.2	0.11	570.0	0.02
二级	1382.2	0.23	1368.9	0.22	1368.9	0.22	13.3	0.00
一级	462.4	0.02	458.8	0.02	458.5	0.02	3.6	0.00
总计	5781.4	0.10	5194.4	0.09	5032.6	0.09	586.9	0.01

注：总计行的占比均为该列药品使用量对药品总使用量的占比；三级行的占比均为该列药品使用量对三级医院药品总使用量的占比；二级与一级同理。

（六）创新药品总平均进院率为 3.0%，谈判药品为 14.0%

由图 2-6、表 2-6 可知，创新药整体平均进院率普遍极低，但呈现逐年快速提升态势，从 2021 年的 1.0% 增至 2023 年的 4.3%。

数据分析显示，医保支付是进院的关键驱动因素：从进院率高低来看，谈判创新药≈医保创新药>总创新药>非医保创新药。创新药总体平均进院率为 3.0%，医保内与谈判创新药的进院率为 4.4%，显著高于非医保创新药（0.7%）。从医院层级看，创新药进院率呈现鲜明的阶梯特征，三级医院最高（9.9%），远高于二级（2.7%）和一级医院（1.3%），且该差距在各类药品（医保创新药、谈判创新药、非医保创新药）中均保持一致。

表 2-6 各级医院各类药品平均进院率

药品类型	三级医院 (%)	二级医院 (%)	一级医院 (%)	总体平均进院 率 (%)
创新药（全部）	9.9	2.7	1.3	3.0
医保目录内创新药	14.1	3.7	2.1	4.4
谈判创新药品	14.0	3.7	2.1	4.4
医保目录外创新药	2.7	0.8	0.2	0.7

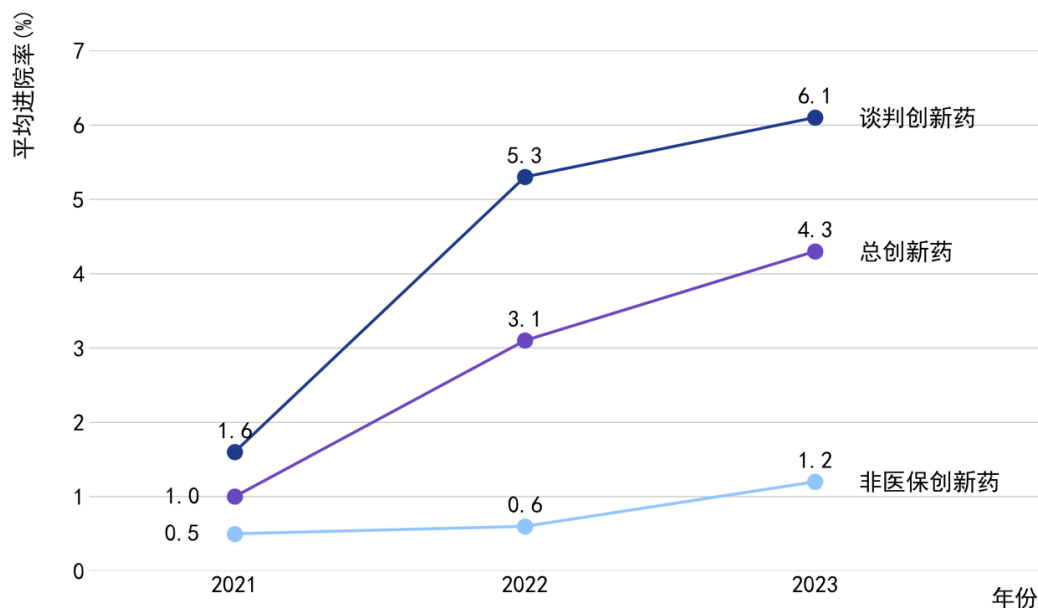


图 2-6 2021-2023 创新药平均进院率

(七) 非医保创新药的均价显著高于医保创新药均价

由表 2-7 可知，创新药的价格分析显示出“双重阶梯”分布特征。

首先，非医保创新药平均单价（108.3 元）显著高于医保创新药（32.1 元），两者差距超过 3 倍。

其次，无论医保属性如何，药品单价均随医院级别升高而递增：三级医院使用的创新药单价最高（56.9 元），远高于二级（7.88 元）和一级医院（4.6 元）。这一规律在各类药品中普遍存在，尤其在谈判创新药中，三级医院单价（47.9 元）达到一级医院（4.2 元）的 10 倍以上，凸显出高价值创新药主要流向了高水平医疗机构。

表 2-7 各级医院各类药品平均单价

药品类型	三级医院 (元)	二级医院 (元)	一级医院 (元)	总体单价 (元)
谈判药品	27.8	8.8	4.2	21.2
创新药（全部）	56.9	7.88	4.6	41.0
医保目录内创新药	46.3	6.3	4.2	32.1
医保目录外创新药	119.2	89.4	50.9	108.3
谈判创新药品	47.9	6.3	4.2	32.6

表 2-8 北京市医院单价最高的十个非医保药品

排名	药品通用名	使用金额（万元）	使用量（个）	单价（元）
1	佩索利单抗注射液	52.0	8	64975.0
2	卡度尼利单抗注射液	277.6	210	13219.7
3	舒格利单抗注射液	84.2	68	12375.0
4	（限消化）恩沃利单抗注射液	44.3	74	5980.0
5	恩沃利单抗注射液	1263.0	2112	5980.0
6	斯鲁利单抗注射液	110.6	198	5588.0
7	利司扑兰口服溶液用散	241.0	482	4998.6
8	派安普利单抗注射液	460.8	1162	3965.3
9	赛帕利单抗注射液	38.0	115	3300.0
10	注射用卡瑞利珠单抗	4299.5	13621	3156.5

（八）抗肿瘤创新药使用金额最高，心血管系统创新药使用量最高

按照使用金额排序，抗肿瘤创新药使用金额最高，抗感染、神经系统、心血管系统次之。

按照使用量排序，心血管系统创新药使用量最高，抗感染、抗肿瘤领域次之。

表 2-9 各治疗领域创新药使用情况

治疗领域	药品种类	数量（个）	使用量（亿）	使用金额（亿元）
抗肿瘤药物	全部创新药	32	0.1	14.8
	谈判创新药	24	0.09	12.3
抗感染药物	全部创新药	10	0.13	1.4
	谈判创新药	8	0.12	1.2
神经系统用药	全部创新药	8	0.07	2.6
	谈判创新药	5	0.06	2.4
心血管系统用药	全部创新药	5	0.20	1.4
	谈判创新药	3	0.20	1.3
内分泌系统用药	全部创新药	4	0.03	0.5
	谈判创新药	3	0.02	0.4

（九）使用金额前十名的创新药主要为化学药品，抗肿瘤药 7 种

使用金额前十位的药品中，生物制品共 2 种（占比 20%），包括替雷利珠单抗注射液（1.9 亿元，10.3%）、注射用卡瑞利珠单抗（1.0 亿元，10.4%）。

化学药品共 8 种（占比 80%），包括甲磺酸阿美替尼片（1.5 亿元，6.5%）、依达拉奉右莰醇注射用浓溶液（1.5 亿元，12.2%）、海曲泊帕乙醇胺片（1.1 亿元，4.9%）、甲苯磺酸尼拉帕利胶囊（0.9 亿元，6.5%）、泽布替尼胶囊（0.7 亿元，5.4%）、海博麦布片（0.6 亿元，14.6%）、甲磺酸伏美替尼片（0.5 亿元，2.9%）、盐酸恩沙替尼胶囊（0.3 亿元，2.5%）。

按照治疗类别划分，7 个是抗肿瘤药物（占比 70%），另外 3 个分别是神经系统用药（占比 10%）、血液系统用药（占比 10%）、心血管系统用药（占比 10%）。

前 10 位创新药品上市与纳入医保平均时间差为 9.8 个月。上市与纳入医保时间差最短的是依达拉奉右莰醇注射用浓溶液，上市时间为 2020 年 7 月 29 日，纳入医保时间为 2020 年 12 月 28 日，时间差为 5.1 个月。最长的是注射用卡瑞利珠单抗，上市时间为 2019 年 5 月 29 日，纳入医保时间为 2020 年 12 月 28 日，时间差为 19.3 个月。

表 2-10 使用金额前十的创新药各年使用数据

药品名称	价格（元）			使用量（单位：万片、粒、支）			使用金额（万元）		
	2021 年	2022 年	2023 年	2021 年	2022 年	2023 年	2021 年	2022 年	2023 年
替雷利珠单抗注射液	2180.0	1450.0	1377.5	1.3	3.5	7.8	2944.2	5158.8	10607.7
甲磺酸阿美替尼片	176.0	176.0	100.8	17.4	1.8	10.3	3068.1	5763.4	6437.1
依达拉奉右莰醇注射用浓溶液	46.5	48.1	35.8	65.6	139.6	144.7	3051.0	6718.4	5181.6
海曲泊帕乙醇胺片	409.7	126.1	126.1	0.1	1.7	4.4	27.0	2932.8	7573.3
注射用卡瑞利珠单抗	2928.0	2928.0	2576.6	1.4	1.0	1.0	4299.5	2871.8	2608.5
甲苯磺酸尼拉帕利胶囊	200.0	200.0	152.8	6.9	0.6	1.1	1457.6	2842.2	5039.7
泽布替尼胶囊	99.0	99.0	85.0	11.1	0.4	0.8	1117.0	2154.4	4131.1
海博麦布片	6.7	6.7	6.7	0.0	17.5	44.9	0.0	1626.4	4195.5
甲磺酸伏美替尼片	571.4	118.0	95.8	0.0	0.4	8.2	0.0	1297.8	3591.0
盐酸恩沙替尼胶囊	203.7	58.8	49.1	0.5	1.3	5.4	211.3	1047.8	1974.6

注：本节如海博麦布片（0.6 亿元，14.6%）括号内内容为（使用金额，平均进院率）。

（十）38 个创新药无使用数据

2021-2023 年，北京市医院无使用数据的创新药共有 38 个，其中 25 个药品为 2023 年获批，从上市到使用有时间差，因此不纳入分析。

纳入分析的无使用数据创新药共有 13 种，均为国产创新药。其治疗领域分

布为：抗感染药物（4 个）位居前列，抗肿瘤药物（3 个）次之，神经系统药物有 2 个，疫苗、麻醉用药、细胞治疗和心血管系统药物各有 1 个。

表 2-11 2019 年-2022 年无使用数据创新药

药品名称	药品种类	单价（元）	持有人	适应症	国产
甘露特纳胶囊	神经系统用药	21.3	上海绿谷制药	轻中度阿尔兹海默症	是
可利霉素片	抗感染药物	2500.0	上海同联制药	上呼吸道感染	是
盐酸拉维达韦片	抗感染药物	51.1	歌礼生物科技	丙型肝炎	是
磷酸依米他韦胶囊	抗感染药物	62.0	宜昌东阳光长江药业	丙型肝炎	是
重组结核杆菌融合蛋白（EC）	疫苗	163.4	安徽智飞龙科马生物制药	结核杆菌感染诊断	是
注射用磷丙泊酚二钠	麻醉用药	156.0	宜昌人福药业	麻醉药	是
瑞基奥仑赛注射液	细胞治疗药物	1290000.0	药明巨诺	复发或难治性大 B 细胞淋巴瘤	是
枸橼酸爱地那非片	心血管系统用药	57.5	悦康药业	勃起功能障碍	是
艾诺米替片	抗感染药物	24.2	艾迪药业	艾滋病	是
甲苯磺酰胺注射液	抗肿瘤药物	8600.0	天津红日健达康医药	中央型非小细胞肺癌成人患者	是
琥珀酸莫博赛替尼胶囊	抗肿瘤药物	335.6	武田新药	含铂化疗期间或之后进展且携带表皮生长因子受体（EGFR）20 号外显子插入突变（ex20ins）的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者	是
盐酸托鲁地文拉法辛缓释片	神经系统用药	38.6	绿叶制药	抑郁症	是
普特利单抗注射液	抗肿瘤药物	6666.0	乐普生物	不可切除或转移性的高度微卫星不稳定型（MSI-H）或错配修复缺陷型（dMMR）的晚期实体瘤患者	是

三、影响创新药在北京市医疗机构配备的原因

课题组于 2025 年 6-8 月，采用线上问卷与实地调研相结合的方式，围绕“创新药品在北京医疗机构谈判入院情况”开展专题调研，并召开了企业座谈会。调研对象主要涵盖医院药剂科主任或副主任，及创新药企业市场准入和大客户负责人。调研内容聚焦于医院药事会召开情况、对创新药引进的态度、当地对创新药（以谈判药品为主）使用考核管理情况，以及企业创新药品在北京市进院情况等关键议题。

调研结果显示，在 2024 年新版医保药品目录公布后，所有参与调研的医院均召开了药事会，其中部分医院召开了谈判药品专题药事会。

在创新药引进态度上，不同医院差异显著：部分医院秉持“应配尽配”原则，倾向于全面引进具有临床需求的创新药；部分则更为审慎，仅重点引进临床需求明确、用量较大的品种；另有少数医疗机构在创新药配备方面表现保守，工作推进力度不足。

总体来看，谈判创新药在医疗机构配备主要面临量大挑战：一是医院存在多重顾虑，二是政策协同性不足。

（一）医疗机构对创新药安全性和有效性的顾虑

国谈创新药从上市到进入医保目录时间从过去的几年大幅缩减至 6 个月。然而，创新药在临床试验阶段所积累的证据仍相对有限，特别是对于附条件批准上市的创新药，往往只积累了 II 期临床试验数据作为支撑。

对于相同适应症的药品，若医疗机构已配备现有品种，则新引进创新药通常意味着需要对原有药品进行替代。临床医生对创新药的安全性与有效性存在一个逐步熟悉与认知的过程，出于对用药风险的关切，往往难以在短期内完成替换。在多数医院中，创新药的引进需由临床医生首先提出用药申请，再进入药事会评审流程。若临床医生未主动提出需求，则该药品无法进入后续的药事审议程序。

（二）谈判药品落地政策和用药管理考核政策的协同性不足

谈判药品进院使用与医保部门和卫生健康部门的医疗机构用药管理考核政策存在政策协同性不足的问题。

一品两规限制、药占比，以及次均费用增幅、医保总额控制、按病种付费

(DRG/DIP) 等均可能影响创新药品配备使用。

《北京若干措施 2024》已经提出取消医疗机构药品数量限制，推动建立医疗机构药事会规范化流程，国谈药目录公布后一个月内召开药事会，全年药事会召开不少于 4 次等，从政策层面给予了一定保障。但由于各医院情况不同，仍有较多医院在内部管理中未及时优化更新。如首都医科大学附属医院和北京大学附属医院等基本按时召开药事会，部分医院则无法达到要求，且有些医院召开药事会未必关注创新药。某跨国企业提供的数据，近 5 年在企业重点关注的 550 家医疗机构中，平均每年医疗机构仅召开 320 次药事会。

尽管北京市若干措施围绕国谈创新药出台了一系列“松绑”政策，但部分医疗机构的一些关键负责人对相关政策认知不足，对国谈药品配备使用的顾虑始终存在。

调研结果显示，公立医院绩效考核方面，影响创新药，尤其是高值国谈药品处方使用的主要是“医疗收入增幅”、“次均费用增幅”、“基本药物占比”等指标。

医保总额控制是医院引进创新药的首要顾虑。尽管国家医疗保障局在《关于政协十三届全国委员会第五次会议第 00769 号（医疗卫生类 068 号）提案答复的函》中明确表示，医疗机构不得以医保总额控制、药占比等为由影响国谈药品配备、使用。北京市也于 2024 年公布了第一批 CHS-DRG 付费新药新技术除外支付名单，涉及 18 个药品，其中 10 个为国谈药品，但除外支付比例相对仍较低，医疗机构在实际操作中对医保费用控制计算依旧存在较大顾虑。

其次是品规数量限制和基本药物占比考核。北京基本取消了品规数限制，但医疗机构对临床科室提起新药进院申请的数量有限制，一个科室最多可提请 2-3 个品种，甚至可能没有资格提交申请。相比之下，国谈药有 570 种，很难得到临床科室提名推荐进院的名额。

集采药品和基本药物使用考核和配备创新药之间的冲突。国谈药物配备没有指标任务，集采药配备则有指标任务且必须完成。引入和采购创新药，意味着替代集采药，可能会导致集采任务量无法完成，考核不合格。医保局招标采购部门在每一批药品集中采购执行后，通过制定可替代药物名单动态监测医疗机构集采同类品种的使用情况。

门诊患者基本药物处方占比、住院患者基本药物使用率、基本药物采购品种

数占比（如三级公立医院不低于 30%）等指标，也会直接影响医院创新药引进和使用。

DRG/DIP 支付标准低、药占比考核、次均费用考核、医疗服务收入占比考核也是国谈药品引进的顾虑因素，特别是对住院患者。除去北京市明确规定的 18 个除外支付的药品，都会计入医疗机构的 DRG 费用内。

国谈创新药从协议期内谈判药品身份转入常规乙类目录管理后，在国家公立医院绩效考核中不再属于除外药品费用的范围，也会计入医疗机构药占比考核，医疗机构则会减少用量。

对于大多数国谈新药而言，只有首个协议期的第一年有优先入院的政策红利（入院率很低），续约产品包括新增药品适应症则不再享有优先入院的政策待遇，若第一年不能入院，此后入院机会更小。

“双通道”政策开通后，一些医院为减轻医院考核负担，更倾向于通过药店供应药品，对谈判药品引进持更加保守态度。对于“双通道”药店可以供应的药品，更倾向于不引进。

对于未进入医保目录的自费创新药进院更是面临诸多阻碍，难以顺利进入医疗机构常备药品目录。

（三）财务和管理成本影响部分医疗机构配备主动性

调研中，部分企业和医疗机构反馈，有些医疗机构会考虑新药进院带来的相关财务成本和管理成本，从而对创新药配备使用缺乏主动性。

药品“零加成”下创新药引进不会带来医院收入，高值药品可能会给医院带来一定的资金成本；而用药目录管理、药品库存管理、特殊剂型药品贮藏管理、药品临时采购管理等也会在一定程度上增加医院的管理成本，导致部分医院的积极主动性不足，少数医院甚至会不考虑建立临时采购渠道。

（四）临时采购入院比例较低，路径受限

一些创新药虽然可以通过临时采购路径入院，但多数仅适用于疑难危重症，短缺药品或高值罕见病药品，在临床急需时，才考虑以临时采购方式采购。部分医院设有罕见病药品临时采购绿色通道，可以较快完成临时采购审批。但对于没有开辟绿色通道的医院，或虽开辟绿色通道，但仍需经药事会批准的，则需要 1-2 个月或更长时间才能完成临时采购审批。少数医院还会因患者数量过少、药品

价格昂贵而拒绝临时采购申请。

此外，对于临时采购途径入院，医疗机构里往往只有个别医生能够处方临时采购的药品，有些直接面向患者的医生没有处方权，通过此路径进院创新药路径往往受限。

四、影响创新药通过双通道模式配备使用的原因

2023 年 9 月 26 日，北京市医疗保障局出台《关于进一步做好国家医保谈判药品落地试点工作的通知》，选取 23 家门诊量大、国谈药采购数量少的定点医疗机构开展“双通道”管理试点工作，由北京市医保经办机构组织 23 家试点医疗机构，确定定点零售药店（简称协议药店），签订三方协议。配套政策对参保人员门诊和住院就医时在协议药店购药的费用支付、结算等方面做出了规定。

2025 年 4 月 7 日，《北京若干措施 2025》明确，国家医保谈判药品直接纳入全市定点医疗机构药品目录，医疗机构可通过“双通道”药店实现“应开尽开”。支持创新药目录药品通过绿色通道快速挂网，不计入基本医保自费率指标并通过“双通道”药店保障供应。种种政策显示，北京市已经在调动多部门从政策层面联合发力，巩固多维度支持创新医药产业发展态势。但调研发现，“双通道”管理下依旧存在诸多问题，主要包括药品目录对往年国谈药品覆盖不足，处方流转未充分畅通，门诊开具的“双通道”药品处方可能存在报销缺口，“双通道”药店药事服务能力不足，医疗机构存在管理风险等。此外，部分医院在执行中出现“双通道”变“单通道”的情况，与国家出台“双通道”的政策初衷出现偏差。

（一）双通道药品目录覆盖仅关注当年国谈创新药

企业反馈，“双通道”药品目录在遴选药品时主要关注最新批次国谈药品，而放松了对往年国谈药品的保障。如北京医院是首批试点医院，目前双通道药店配备数量大概是 83 种，品规数量有 103 个，2024 年总共开出 3746 张双通道处方，金额 600 多万元，列入双通道的品种和使用都较少。

部分医疗机构出于安全性和管理风险考虑，不允许配备注射液或冷链药品。临床医生开具双通道药品处方通常不受限制，但部分处方可能缺乏合理性，存在超适应症用药、重复用药等医疗风险，医疗机构需花费额外精力进行处方审核和用药监控，增加了管理成本和工作负担。

（二）电子处方开具和流转管理存在滞后

北京市已搭建了处方流转平台，高值药品外配处方的流转方式逐渐从过去的纸质处方和电子处方共存转向电子处方为主，特别是国家医保局新政要求 2025 年 1 月 1 日起，配备“双通道”药品的定点零售药店均需通过医保电子处方流转中台接收电子处方，不再接受纸质处方，进一步打通院内外药房壁垒。

创新药通过电子处方流转至双通道药店，提高了部分创新药进院比例，但由于部分医疗机构禁止开具纸质外配处方，导致了一些国谈创新药的外配处方实际上无法开具，管理机制的衔接出现断层。

（三）外配药品费用纳入医保总额可能影响药品可及

从便于医保基金监管和药品使用监测考虑，部分医疗机构开具的“双通道”外配药品费用纳入相应医疗机构的医保总额或按病种付费，一定程度上可能给医师处方“双通道”药品带来顾虑。

为保障用药安全和基金安全，“双通道”政策普遍实行定医疗机构、定零售药店、定责任医师的“三定管理”。北京市对定点药店的选择更关注是否是连锁药店、距离远近和是否有国谈药品使用经验等，双通道药店目前数量有限，患者需要步行很远的距离，尤其是多院区的医疗机构只有一个双通道药店，患者跨院区取药距离通常在 10 公里以上，对需冷链储存的药品，进一步增加了患者取药和携带的难度。此外，患者观念里也会对药店取药的合规和质量产生质疑。

（四）“双通道”配套报销保障政策不足

“双通道”政策要求，对纳入“双通道”管理的药品，在定点医疗机构和定点零售药店执行统一的支付政策。具体落地中，对于住院期间发生的外配药品费用，通常按照住院报销规则进行报销；对于非住院期间发生的药品费用，包括门（急）诊开具的“双通道”外配药品，则按门诊报销政策进行报销，但创新药不在门诊慢特病、门诊特殊药品政策范围内，则意味着患者只能通过门诊统筹报销，但普通门诊统筹对高值创新药保障能力有限。虽然北京市已经明确异地参保人员来京就医通过“双通道”管理定点零售药店，购买国家医保谈判药品可以医保报销，但需由参保人员垫付，异地报销，各地政策差异较大，患者实际报销难度极大。此外，对于商业保险，二次报销是需要医院发票的，药店发票无法报销。

（五）双通道药店药事服务能力与医院相比有差距

“双通道”药店在药事服务能力上与医院药房相比往往存在一定的差距，且双方普遍未建立协作机制，导致医院对启用“双通道”配备药品存有顾虑。医院无法为“双通道”药店的药师提供培训，也无从得知药店药师是否为患者提供了必要的用药信息讲解，因此部分医院只将副作用小、易于掌握用法的口服药、皮下注射剂放入“双通道”药店管理，以保障患者的用药安全。

事实上，很多创新药都是注射剂品种，静脉注射、肌肉注射类药品均需由医护人员完成。部分医疗机构对于外配注射类药品不提供输注服务，注射类外配药品如何使用是长期困扰患者用药的难点。通过“双通道”药店购买注射类药品后主要有三种用药方式：一是药店将药品配送至开具处方的医院，医院提供输注服务，患者不接触药品；二是药店设有诊所或输注中心，能为患者提供购药、输注一站式服务，通常只限于拥有医院或门诊的少数大型连锁药店。但在一些情形下，药店不提供输注服务和配送，需要由患者自行携带药品至医疗机构完成输注。考虑药品在运输过程中可能被污染，或因冷链条件不达标造成药液变质，大部分医疗机构通常不允许为外院处方的药品提供输注服务，即使对于本院开具处方的外配药品，有时候也不允许在院内使用，带来用药不便。

（六）双通道可能变成单通道影响创新药进医院

双通道很大程度上缓解了创新药的困惑，为进院难开辟了一个新渠道，门诊用药也相对便利。但部分医疗机构在实际执行中出现“双通道”变“单通道”的情况，有的医院出于药品零加成、医院药品品规数量限制和费用控制考虑，对已开通双通道的药品更倾向于不予引进，与国家出台“双通道”的政策初衷出现偏差，也增加了患者临床用药安全风险。

创新药进院模式和路径尚未完全顺畅，双通道对解决临床急需创新药供应发挥了过渡性保障作用，但从患者购药便利性、用药安全性、服务专业性和基金监管等角度，药店都无法与医院相比，而且目前用药也仅为医院渠道的10%左右，难以解决长久问题。

对于国谈创新药，医保部门要求双通道药店零差率，药店会要求企业在国谈确定的医保支付标准的基础上有一定折扣，通过降低进货价来弥补自身经营成本和增加利润，因此进一步压缩了创新药的利润。而对不少高值创新药而言，难以达到国谈要求，而自费药品也无法享受双通道政策。

五、完善北京市医疗机构创新药配备及使用模式的政策建议

随着国家全链条支持创新药发展各项政策的落地，以及国家医保药品谈判制度常态化，迫切需要建立长效的创新药准入与落地政策机制，系统的理顺创新药品落地的“最后一公里”政策体系。北京作为全国生物医药产业和医疗资源高地，肩负着先行先试、引领示范的使命。建议北京市医保和卫生健康部门对标《国家医疗保障局 国家卫生健康委关于适应国家医保谈判常态化持续做好谈判药品落地工作的通知》（医保函〔2021〕182 号）、《国家医保局 国家卫生健康委关于建立完善国家医保谈判 药品“双通道”管理机制的指导意见》（医保发〔2021〕28 号）的各项措施，逐条逐项落实。特别是《北京若干措施 2024/2025》提到的有关事项，要积极评估政策在北京市的落地执行力度，北京市医保和卫生健康部门应及时制定发布相应政策细则，在各项影响创新药品进院和谈判药品落地的医保费用管理、药品使用管理考核指标上真正为医疗机构“松绑”，消除医疗机构合理配备使用谈判药品的顾虑，定期跟进医院药品配备情况。

课题工作组基于对北京市过去三年对创新药品的使用情况数据分析和调研结果，借鉴部分地区实践经验，提出以下意见建议。

（一）细化政策措施，明确创新药进院的路径和方式

《北京若干措施 2025》虽然明确了国家医保谈判药品直接纳入全市定点医疗机构药品目录，医疗机构可通过“双通道”药店实现“应开尽开”，但具体路径上尚不清晰。建议北京市相关部门出台配套措施，明确列入院内常备药品目录应作为主要的配备渠道，双通道作为院内无法及时配备时的补充途径，避免医疗机构基于考核指标的考量，将双通道配备作为主要的配备渠道。同时明确创新药纳入医疗机构药品目录的具体流程，对于参与创新药临床试验或真实世界研究的医疗机构，可凭借伦理批件和临床试验数据，直接申请将该创新药纳入医疗机构临时采购目录，减少对临床科室每年提交新药申请数量的限制，取消“以替换方式引进新药”。

同时，建议对《北京若干措施 2025》中提及的“对开展真实世界研究的医疗机构给予资金支持”明确落实细则，通过设置纵向课题等形式鼓励医疗机构申请专项，用于评价国谈创新药品的真实世界使用效果，为临床配备提供科学依据。

（二）督促医疗机构及时召开针对国谈药品的药事会

建议北京市医保局和北京市卫健委会同有关部门，发文督促医疗机构在每年新版药品目录公布后的 1 个月内召开药事会（非执行后的一定期限），其中针对创新药论证的药事会每年不少于 2 次。文件出台后，建议各区医保和卫健部门对医疗机构药事会召开情况进行跟进，对没有及时召开的医疗机构督促其尽快召开，且明确药事会的召开是为了研究国谈创新药的进院问题。江苏、浙江、上海等多地经验显示，细化医疗机构药事会召开时限要求并跟进执行情况，对加快进入国谈目录的创新药品进院有显著促进作用。

此外，对于国谈创新药品，建议医疗机构对外公布药事会开启的时间、流程以及规范化的临床科室推荐流程。向社会公开国谈新药在各医疗机构的配备情况，便于患者知晓哪里可以配到所需药物。

（三）将创新药准入和配备使用纳入医疗机构考评体系

建议将创新药品准入和配备情况纳入医疗机构考评体系。将创新药品配备品种数纳入三级、二级公立医院绩效考核体系；将创新药品配备品种数（如，重点三级公立综合医院的创新谈判药品配备率原则上不低于 30%）和召开药事会情况纳入合理用药考核和医疗机构负责人绩效考评体系，设置具体量化指标，从而提高医疗机构对创新药品配备使用工作的重视，形成医疗机构主动配备使用创新药品的长效促进机制。例如，上海将国谈药品配备数量作为合理用药考核的评分指标，安徽和江苏将国谈药品药事会召开情况作为合理用药考核的评分指标。

还应定期（例如按月或按季）统计、通报、公示医疗机构创新药品配备和使用情况，对配备品种数不合理、配备但不使用等情况进行调研纠正。

（四）优化创新药品准入和使用考核

建议北京市卫生健康部门与医保部门、以及财政部门联动，建立创新药品费用单独核算机制，并细化完善与创新药品相关的药品使用考核体系。一方面对创新药使用和费用情况单独开展统计、监测、评估，指导药品使用考核体系、医保付费政策等配套政策的制定调整，如将创新药品从总体考核体系中除外计算或单独核算，医疗机构品规数量、基本药物占比、医疗服务收入占比的计算基数中剔除创新药等；另一方面，在医疗机构财务体系中将创新药品收入拆分统计，有助于创新药品使用考核“松绑”政策顺畅落地。同时，随着医保谈判、国家集采和基本药物等重要制度的推进，医疗机构临床用药结构正在发生巨大变化，调整医

疗机构药品费用核算方式，对创新药、基本药物等进行单独统计，也有利于相关制度落地后配套监测分析的长效开展。同时，各级卫生健康部门应加强对医疗机构特别是中医院的政策宣传培训，指导医疗机构优化内部考核评价体系，为创新药按需使用留出空间。

（五）加强医保部门、卫生健康部门和药监部门协同

建议加强北京市医保部门与卫健以及药监部门的协同合作，推动创新药进院使用并确保质量安全。建立部门间长效协作机制，例如围绕创新药品上市、准入和配备使用成立市级跨部门专项工作小组以及沟通协作机制，明确各方工作分工。三方协同开展创新药品上市准入落地政策宣传交流，定期沟通创新药配备和使用中的问题，及时协商解决。加强三部门间的政策协调，对于调研发现的可能影响创新药品合理配备使用的管理考评政策和质量担忧等，共同研究，协调推进。

建议卫生健康部门指导医疗机构将用药目录管理的相关要求、召开药事会的相关要求写入《医疗机构药事管理规定》等文件中，或出台针对性指导文件，指导医疗机构尽快建立与医保谈判联动的用药目录动态调整机制，定期淘汰不使用、风险效益比或成本效益比低的药品，为创新药腾挪空间。

（六）提高医疗机构对支持创新药发展相关政策的认识

建议北京市医保部门联合卫生健康部门，在每年新版药品目录公布后，组织重点医疗机构的院长、医保办主任、药剂科主任等关键岗位负责人召开政策宣传交流会，就创新药医院准入和配备使用政策进行宣介，尤其是对医保和卫生健康部门的相关“松绑”政策，例如国谈药品不占医保总额、不计入 DRG/DIP 支付标准、不占品规数量和药占比等，进行详细培训解读，促使医疗机构打消相关政策性顾虑、理解和支持国谈药品落地工作。也可考虑借鉴江苏省、上海市、广东省等经验，在国谈前后，利用政府平台组织企业和医疗机构开展创新药信息沟通，及时传递创新药临床价值。

（七）完善“双通道”政策管理

1.完善“双通道”药品购药和异地购药报销政策，确保其覆盖所有参保人群。同时建议将“双通道”药品纳入北京市门诊特殊药品政策保障范围，提高对高值药品的保障能力。

2.优化目录管理。建议加强医保部门、卫生健康部门和相关医疗机构的协调，完善目录遴选标准，系统梳理各批次国谈药品中临床价值高、患者急需、替代性不高的品种，及时调整纳入目录，开展动态增补调整，提高“双通道”药品目录制定的科学性规范性，确保医保报销待遇的延续性。

3.完善“双通道”药品处方开具和流转的管理细节。一是完善“双通道”电子处方流转平台建设，畅通目录外药品的处方开具方式；二是完善过渡期间电子处方与纸质处方的衔接，指导医疗机构完善外配处方管理方式，打通纸质处方流转链条；三是对在“双通道”零售药店规范销售使用的“双通道”药品予以单列，暂不纳入就诊医疗机构医保总额控制范围，以打消医疗机构的用药顾虑；四是适时扩大定点医药机构和药店数量，提高“三定”信息公开性。

4.建议对医药使用“双通道”药店购买的药品设置激励措施或提供一定基础保障，如鼓励医疗机构在门诊和住院部为患者提供处方外配药品的输注和服用指导，确保患者用药安全、减轻医疗机构药品管理负担。同时，相关部门应督促医疗机构提高药事管理水平，适时提供院内使用“双通道”药品的场所，加强对医护人员使用新国谈药品使用的培训和指导。

5.建议推动定点药店加强执业药师专业能力建设，强化对药店人员的业务培训与考核，确保“双通道”药品的配送和使用规范安全、服务专业。

6.鼓励医疗机构与定点药店建立稳定配送关系，提升患者药品获取便捷性，特别是为保障冷链药品及特殊储存条件药品的使用安全，应建立相应的长效机制。

7.建议卫健、药监局和医保局协作，明确医院和药店的安全责任划分，形成相关责任条款，督促医院建立完善的药品外配管理机制。

（八）优化创新药临时采购入院通道

1.建议卫生健康部门指导医疗机构完善目录外药品临时采购制度，推动医疗机构普遍建立和畅通药品临时采购渠道，优化临时采购流程。例如减少对创新药品临时采购的病人数、采购量、采购次数限制，对同一患者非首次使用申请用药简化流程，缩短审批周期，使确有需求的患者及时用上创新药。

2.针对罕见病等特殊疾病用药，建议建立绿色临采通道，一旦出现临床需求应简化引进手续，缩短临时采购审批时间，按需采购使用，满足患者用药需求。

附录：

一、术语解释

创新药：国家药品监督管理局批准的 I 类化药和生物制品。

医保创新药：被纳入国家基本医保目录的创新药。数据统计时以北京市医药卫生科技促进中心数据库中医保数据列标记为“Y”的，即算作医保药品。

非医保创新药：没有纳入国家基本医保目录的创新药。数据统计时以北京市医药卫生科技促进中心数据库中医保数据列标记为“N”或者空的，即算作非医保药品。

谈判创新药：国家医疗保障局药品谈判成功并纳入国家基本医保目录的创新药。

药品使用金额：药品的销售金额，数据库中 I 列。

药品使用量：药品的销售制剂量，而非销售包装量。在数据库的 J 或 K 列。

毛配备率 = 公立医院有使用数据的创新药数量/已批准的创新药总数

谈判创新药配备率=公立医院使用的谈判创新药数量/谈判成功创新药总数

进院率 = 该年度创新药有使用记录的(级别)公立医院数

/ (级别) 公立医药医院总数

平均进院率=不同年份不同级别间平均进院率的计算为医院数量的加权平均

药品单价 = 使用金额 (销售金额) / 使用量 (销售制剂量)

二、2021-2023 年北京市公立医院药品使用数据分析表格汇总

（一）各级公立医院各类药品用量、金额、平均进院率数据统计

1. 药品、医保药、非医保药数据统计表

表 1 2021-2023 年北京市公立医院药品使用情况

公立医院级别	年份	药品用量 (亿)	占总药品比 (%)	使用金额 (亿)	占总药品比 (%)
一级	2021	67.2	12.1	85.7	5.5
	2022	73.6	13.3	95.8	6.2
	2023	83.4	15.1	121.3	7.8
	总计	224.3	40.5	302.7	19.5
二级	2021	21.2	3.8	47.4	3.1
	2022	24.8	4.5	49.3	3.2
	2023	15.1	2.7	35.9	2.3
	总计	61.1	11.0	132.6	8.5
三级	2021	95.9	17.3	364.2	23.4
	2022	87.9	15.9	336.4	21.6
	2023	102.8	18.6	419.5	27.0
	总计	286.6	51.8	1120.1	72.0
总计		572	100	1555.5	100

表 2 2021-2023 年北京市公立医院医保药品使用情况

公立医院级别	年份	药品用量 (亿)	占医保药品 比 (%)	使用金额 (亿)	占医保药品 比 (%)	平均进院 率
一级	2021	63.7	11.6	76	5.5	19.5%
	2022	71.3	13.0	90.4	6.5	18.9%
	2023	81.8	14.9	116	8.4	19.8%
	总计	216.9	39.6	282.3	20.4	19.4%
二级	2021	19.7	3.6	41.2	3.0	19.0%
	2022	23.8	4.4	45.7	3.3	19.4%
	2023	14.6	2.7	33.8	2.4	19.4%
	总计	58.1	10.6	120.6	8.7	19.3%
三级	2021	88.9	16.2	298.2	20.9	27.1%
	2022	84.1	15.4	303.8	21.9	28.6%
	2023	99.7	18.2	379.1	27.4	27.8%
	总计	272.7	49.8	981.1	70.9	27.8%
总计		547.7	100	1384.1	100	21.2%

表 3 2021-2023 年北京市公立医院非医保药品使用情况

医院级别	年份	使用量 (亿)	占非医保药品 比 (%)	使用金额 (亿)	占非医保药品 比 (%)
一级	2021	3.5	14.4	9.7	5.7
	2022	2.3	9.5	5.4	3.2
	2023	1.6	6.6	5.3	3.1
	总计	7.4	30.5	20.4	11.9
二级	2021	1.5	6.2	6.2	3.6
	2022	1	4.1	3.6	14.8
	2023	0.5	2.1	2.1	8.6
	总计	3	12.4	11.9	7.0
三级	2021	7	28.8	66	38.5
	2022	3.8	15.6	32.6	19.0
	2023	3.1	12.8	40.4	23.6
	总计	13.9	57.2	139	81.1
总计		24.3	100	171.3	100

2. 谈判药品数据统计表

表 4 2021-2023 年北京市公立医院谈判药品使用情况

医院级别	年份	使用量 (亿)	占谈判药品 比 (%)	使用金额 (亿)	占谈判药品比 (%)	平均进院率 (%)
一级	2021	0.2	2.5	0.5	0.4	5.7
	2022	0.5	7.7	1.9	1.4	4.6
	2023	0.6	10.1	3.0	2.2	3.8
	小计	1.3	20.3	5.4	4.0	4.7
二级	2021	0.1	1.4	0.5	0.4	9.7
	2022	0.3	4.0	2.8	2.1	7.1
	2023	0.2	3.0	2	1.5	5.6
	小计	0.6	8.4	5.3	3.9	7.4
三级	2021	0.3	5.4	3.8	2.8	27.2
	2022	1.7	26.5	48.8	35.9	21.2
	2023	2.5	39.5	72.6	53.4	21.1
	小计	4.5	71.3	125.2	92.1	23.2
总计		6.4	100	135.9	100	11.4

3. 创新药数据统计表

表 5 2021-2023 年北京市公立医院创新药使用情况

医院级别	年份	使用量 (万)	占总使用 量比 (%)	使用金额 (万)	占总使用金额比 (%)	平均进院率 (%)
一级	2021	0.03	0.0	1.1	0.0	0.1
	2022	231.8	4.0	766.4	0.3	1.5
	2023	230.5	4.0	1360.9	0.6	2.3
	小计	462.4	8.0	2128.3	0.9	1.3
二级	2021	13.7	0.2	773.2	0.3	0.7
	2022	154.3	2.7	2665.2	1.1	2.7
	2023	1214.2	21	7452.8	3.2	4.6
	小计	1382.2	23.9	10891.3	4.6	2.7
三级	2021	258.2	4.5	48680.9	20.6	4.2
	2022	725.9	12.6	53381.1	22.5	9.8
	2023	2952.7	51.1	121835.3	51.4	15.2
	小计	3936.8	68.1	223897.3	94.5	9.9
总计		5781.4	100.00	236916.9	100.0	3.0

表 6 2021-2023 年北京市公立医院医保创新药使用情况

医院级别	年份	使用量 (万)	占总使用量比 (%)	使用金额 (万)	占总使用金额比 (%)	平均进 院率 (%)
一级	2021	0.03	0.0	1.0	0.0	0.1
	2022	231.8	4.0	765.9	0.3	2.9
	2023	226.9	3.9	1178.3	0.5	2.8
	小计	458.8	7.9	1945.2	0.8	2.1
二级	2021	12.6	0.2	451.8	0.2	1.3
	2022	144.8	2.5	2149.2	0.9	4.4
	2023	1211.5	21.0	6079.7	2.6	5.5
	小计	1368.9	23.7	8680.7	3.7	3.7
三级	2021	196.8	3.4	8418.4	3.6	7.0
	2022	637.0	11.0	38323.5	16.2	16.0
	2023	2533.0	43.8	109218.3	46.1	18.7
	小计	3366.8	58.2	155960.1	65.8	14.1
总计		5194.4	89.9	166586.0	70.3	4.4

表 7 2021-2023 年北京市公立医院非医保创新药使用情况

医院级别	年份	使用量 (万)	占总使用量 占比(%)	使用金额 (万)	占总使用金额占 比(%)	平均进院率 (%)
一级	2021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2022	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
	2023	3.6	0.1	182.6	0.1	0.7
	小计	3.6	0.1	183.1	0.1	0.2
二级	2021	1.1	0.0	321.5	0.1	0.2
	2022	14.1	0.0	1373.1	0.6	0.8
	2023	9.5	0.2	516.0	0.2	1.3
	小计	24.7	0.2	2210.6	0.9	0.8
三级	2021	61.4	1.1	40262.5	17.0	2.3
	2022	88.9	1.5	15057.6	6.4	2.9
	2023	419.7	7.3	12617.0	5.3	3.1
	小计	570.0	9.9	67937.1	28.7	2.7
总计		598.3	10.2	70330.8	29.7	0.7

表 8 2021-2023 年北京市公立医院谈判创新药使用情况

医院级别	年份	使用量 (万)	占总使用量占 比(%)	使用金额 (万)	占总使用金 额占比(%)	平均进院率 (%)
一级	2021	0.03	0.0	1.00	0.0	0.1
	2022	231.8	4.0	765.4	0.3	2.9
	2023	226.7	3.9	1175.2	0.5	2.8
	小计	458.5	7.9	1941.6	0.8	2.1
二级	2021	12.6	0.2	451.7	0.2	1.3
	2022	144.8	2.5	2148.9	0.9	5.5
	2023	1211.5	21.0	6079.7	2.6	4.4
	小计	1368.9	23.7	8680.3	3.7	3.7
三级	2021	196.8	3.4	8418.3	3.6	7.0
	2022	592.8	10.3	37651.7	15.9	15.9
	2023	2415.6	41.8	107433.5	45.3	18.6
	小计	3205.2	55.4	153503.5	64.8	14.0
总计		5032.6	87.0	164125.4	69.3	4.4

注：本小节使用量与使用金额占比均为占创新药总使用金额与总使用量比值

4. 各治疗领域创新药数据统计表

表 9 各治疗领域创新药使用情况

治疗领域	药品数量 (个)	占比 (%)	使用金额 (万)	占比 (%)	使用量	占比 (%)
抗肿瘤药物	32	43.8	148143.3	62.4	990.7	17.1
抗感染药物	10	13.7	13897.6	5.9	1248.6	21.6
神经系统用药	8	11.0	26192.2	11.0	682.0	11.8
心血管系统用药	5	6.8	14204.2	6.0	1987.4	34.4
内分泌系统用药	4	5.5	5297.9	2.2	261.4	4.5
疫苗	4	5.5	337.0	0.1	1.7	0.0
呼吸系统用药	2	2.7	738.6	0.3	18.2	0.3
麻醉用药	2	2.7	5525.6	2.3	63.3	1.1
皮肤科用药	2	2.7	907.4	0.4	6.6	0.1
免疫系统用药	1	1.4	2851.2	1.2	3.5	0.1
消化系统用药	1	1.4	652.0	0.3	58.3	1.0
血液系统用药	1	1.4	17874.2	7.5	142.7	2.5
骨科用药	1	1.4	37.5	0.0	0.02	0.0

表 10 各治疗领域谈判创新药使用情况

治疗领域	药品数量 (个)	占比 (%)	使用金额 (万)	占比 (%)	使用量 (万)	占比 (%)
抗肿瘤药物	24	47.1	122907.3	75.0	890.3	27.8
抗感染药物	8	15.7	12285.6	7.5	1158.3	36.1
神经系统用药	5	9.8	23894.8	14.6	557.3	17.4
内分泌系统用药	3	5.9	4202.5	2.6	238.9	7.5
心血管系统用药	3	5.9	13138.0	8.0	1950.9	60.9
皮肤科用药	2	3.9	907.4	0.5	6.6	0.2
麻醉用药	2	3.9	5525.6	3.4	63.3	2.0
呼吸系统用药	2	3.9	738.6	0.5	18.2	0.6
免疫系统用药	1	2.0	2851.2	1.7	3.5	0.1
消化系统用药	1	2.0	652.0	0.4	58.3	1.8
血液系统用药	1	2.0	17874.2	10.9	142.7	4.5

（二）公立医院使用金额前十的各类药品分析表

1. 使用金额前十的谈判药品分析表

表 11 北京市公立医院使用金额前十的谈判药品

序号	药品名称	上市许可持有人	适应症	成分分类	治疗领域
1	蓝芩口服液	扬子江药业	急性咽炎、扁桃体炎	中成药（板蓝根、黄芩等）	呼吸系统用药
2	司库奇尤单抗注射液	诺华制药	斑块状银屑病、强直性脊柱炎、银屑病关节炎	IL-17A 单克隆抗体	免疫系统用药
3	度普利尤单抗注射液	赛诺菲制药	特应性皮炎、哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉	IL-4R α 单克隆抗体	免疫系统用药
4	百令胶囊	中美华东制药	慢性支气管炎、慢性肾功能不全	发酵虫草菌粉（中成药）	补益剂
5	西妥昔单抗注射剂	默克制药	转移性结直肠癌、头颈部鳞状细胞癌	EGFR 单克隆抗体	抗肿瘤药物
6	金花清感颗粒	聚协昌药业	流感引起的发热、咳嗽、乏力	中成药（金银花、石膏等）	呼吸系统用药
7	甲磺酸阿美替尼片	豪森药业	EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌	EGFR-TKI 抑制剂	抗肿瘤药物
8	艾托格列净片	辉瑞制药	2 型糖尿病	SGLT2 抑制剂	内分泌系统用药
9	沙库巴曲缬沙坦钠片	诺华制药	射血分数降低的慢性心力衰竭	ARNI（血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂）	心血管系统用药
10	丁苯酞氯化钠注射液	石药集团	轻、中度急性缺血性脑卒中	神经保护剂	神经系统用药

表 12 北京市公立医院使用金额前十的谈判药品使用数据

药品名称	价格（元）			使用量（单位：万片、粒、支）			使用金额（亿元）		
	2021年	2022年	2023年	2021年	2022年	2023年	2021年	2022年	2023年
蓝芩口服液	6.0	5.7	5.7	2278.8	2889.6	3656.6	1.4	1.6	2.1
司库奇尤单抗注射液		1184.7	925.6	0.0	15.5	26.2	0.0	1.8	2.4
度普利尤单抗注射液		3150.8	2764.8	0.0	4.7	9.7	0.0	1.5	2.7
百令胶囊	1.1	1.1	1.1	11469.1	11409.8	10750.3	1.3	1.2	1.2
西妥昔单抗注射剂	1340.3			22.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
金花清感颗粒	9.5	8.8	8.9	644.2	789.7	1667.0	0.6	0.7	1.5
甲磺酸阿美替尼片	176.0	176.0	100.8	0.0	36.8	128.5	0.0	0.6	2.2
艾托格列净片	3.5	3.5	3.5	0.0	95.2	48.3	0.0	0.0	2.7
沙库巴曲缬沙坦钠片	3.2	3.2	3.2	0.0	3350.7	5347.1	0.0	1.0	1.7
丁苯酞氯化钠注射液		138.6	120.9	0.0	93.5	109.1	0.0	1.3	1.3

表 13 北京市公立医院使用金额前十的谈判药品谈判及谈判后纳入医保时间

序号	药品名称	谈判时间	谈判后纳入医保时间	谈判与纳入医保时间差（天）
1	蓝芩口服液	2020/12/28	2021/3/1	63
2	司库奇尤单抗注射液	2021/12/3	2022/1/1	29
3	度普利尤单抗注射液	2020/12/28	2021/3/1	63
4	百令胶囊	2020/12/28	2021/3/1	63
5	西妥昔单抗注射剂	2018/10/10	2018/11/1	22
6	金花清感颗粒	2019/11/28	2020/1/1	34
7	甲磺酸阿美替尼片	2021/12/3	2022/1/1	29
8	艾托格列净片	2020/12/28	2021/3/1	63
9	沙库巴曲缬沙坦钠片	2020/12/28	2021/3/1	63
10	丁苯酞氯化钠注射液	2020/12/28	2021/3/1	63
平均时间差				46.6

表 14 北京市公立医院使用金额前十的谈判药品（化药与生物制品）

序号	药品名称	上市许可持有人	适应症	成分分类	治疗领域
1	司库奇尤单抗注射液	诺华制药	斑块状银屑病、强直性脊柱炎、银屑病关节炎	IL-17A 单克隆抗体	免疫系统用药
2	度普利尤单抗注射液	赛诺菲制药	特应性皮炎、哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉	IL-4R α 单克隆抗体	免疫系统用药
3	西妥昔单抗注射液	默克制药	转移性结直肠癌、头颈部鳞状细胞癌	EGFR 单克隆抗体	抗肿瘤药物
4	甲磺酸阿美替尼片	豪森药业	EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌	EGFR-TKI 抑制剂	抗肿瘤药物
5	艾托格列净片	辉瑞制药	2 型糖尿病	SGLT2 抑制剂	内分泌代谢用药
6	沙库巴曲缬沙坦钠片	诺华制药	射血分数降低的慢性心力衰竭	ARNI（血管紧张素受体脑啡肽酶抑制剂）	心血管系统用药
7	丁苯酞氯化钠注射液	石药集团	轻、中度急性缺血性脑卒中	神经保护剂	神经系统用药
8	帕妥珠单抗注射液	德国罗氏	早期乳腺癌、转移性乳腺癌	IgG1 单克隆抗体	抗肿瘤药物
9	重组人血小板生成素注射液	沈阳三生制药	治疗实体瘤化疗后所致的血小板减少症，用于原发免疫性血小板减少症(ITP)的辅助治疗	血小板生成素	治疗和预防用生物制品
10	尼妥珠单抗注射剂	百泰生物药业有限公司	试用于与放疗联合治疗表皮生长因子受体 (EGFR) 表达阳性的 III/IV 期鼻咽癌	EGFR 单克隆抗体	抗肿瘤药物

表 15 北京市公立医院使用金额前十名的谈判药品使用情况（化药与生物制品）

药品名称	价格（元）			使用量（单位：万片、粒、支）			使用金额（亿元）		
	2021年	2022年	2023年	2021年	2022年	2023年	2021年	2022年	2023年
司库奇尤单抗注射液	0	1184.7	925.6	0	15.5	26.2	0	1.8	2.4
度普利尤单抗注射液	0	3150.8	2764.8	0	4.7	9.7	0	1.5	2.7
西妥昔单抗注射剂	1340.3	0	0	22	0	0	2.9	0	0
甲磺酸阿美替尼片	0	156.8	167.6	0	36.8	128.5	0	0.6	2.2
艾托格列净片	0	3.4	3.45	0	95.2	48.3	0	0.03	2.7
沙库巴曲缬沙坦钠片	0	3	3.2	0	3350.7	5347.1	0	1	1.7
丁苯酞氯化钠注射液	0	138.6	120.9	0	93.5	109.1	0	1.3	1.3
帕妥珠单抗注射液	0	4955	4955.3	0	2.2	3	0	1.1	1.5
重组人血小板生成素注射液	0	730.1	730.4	0	12.7	20.5	0	0.9	1.5
尼妥珠单抗注射剂	4832.5	0	0	4.7	0	0	2.3	0	0

表 16 北京市公立医院使用金额前十的谈判药品谈判与谈判后纳入医保时间

序号	药品名称	谈判时间	谈判后纳入医保时间	上市与纳入医保时间差（月）
1	司库奇尤单抗注射液	2021/12/3	2022/1/1	29
2	度普利尤单抗注射液	2020/12/28	2021/3/1	63
3	西妥昔单抗注射剂	2018/10/10	2018/11/1	22
4	甲磺酸阿美替尼片	2021/12/3	2022/1/1	29
5	艾托格列净片	2020/12/28	2021/3/1	63
6	沙库巴曲缬沙坦钠片	2020/12/28	2021/3/1	63
7	丁苯酞氯化钠注射液	2020/12/28	2021/3/1	63
8	帕妥珠单抗注射液	2019/11/28	2020/1/1	34
9	重组人血小板生成素注射液	2017/7/19	2017/9/1	44
10	尼妥珠单抗注射剂	2017/7/19	2017/9/1	44
平均时间差				42.5

2. 使用金额前十的创新药品分析表

表 17 北京市公立医院使用金额前十名的创新药品

序号	药品名称	上市许可持有人	适应症	成分分类	治疗领域
1	替雷利珠单抗注射液	百济神州	经典型霍奇金淋巴瘤、尿路上皮癌、非小细胞肺癌、肝细胞癌、食管鳞癌	PD-1 单克隆抗体	抗肿瘤药物
2	甲磺酸阿美替尼片	江苏豪森药业	用于既往经表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者	EGFR 酪氨酸激酶抑制剂	抗肿瘤药物
3	依达拉奉右莰醇注射用浓溶液	先声药业	用于改善急性缺血性脑卒中所致的神经功能缺损	依达拉奉、右莰醇复方制剂	神经系统用药
4	海曲泊帕乙醇胺片	恒瑞医药	用于免疫性血小板减少症（ITP）成人患者，对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳或不耐受的患者	TPO-R 激动剂（血小板生成素受体激动剂）	血液系统用药
5	注射用卡瑞利珠单抗	苏州盛迪亚生物医药	用于霍奇金淋巴瘤、肝癌、肺癌、食管癌、鼻咽癌等多种肿瘤	PD - 1 单克隆抗体	抗肿瘤药物
6	甲苯磺酸尼拉帕利胶囊	再鼎医药	用于晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗	PARP 抑制剂	抗肿瘤药物
7	泽布替尼胶囊	百济神州	用于治疗成人套细胞淋巴瘤（MCL）患者，及成人慢性淋巴细胞白血病（CLL）	酪氨酸激酶抑制剂	抗肿瘤药物
8	海博麦布片	浙江海正药业	作为饮食控制以外的辅助治疗，可单独或与 HMG - CoA 还原酶抑制剂（他汀类）联合用于治疗原发性（杂合子家族性或非家族性）高胆固醇血症	胆固醇吸收抑制剂	心血管系统用药
9	甲磺酸伏美替尼片	江苏艾力斯	用于既往经 EGFR TKI 治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在 EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者	EGFR 酪氨酸激酶抑制剂	抗肿瘤药物
10	盐酸恩沙替尼胶囊	贝达药业	用于此前接受过克唑替尼治疗进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者	ALK 酪氨酸激酶抑制剂	抗肿瘤药物

表 18 北京市公立医院使用金额前十名的创新药品使用情况

药品名称	价格（元）			使用量（单位：万片、粒、支）			使用金额（万元）		
	2021年	2022年	2023年	2021年	2022年	2023年	2021年	2022年	2023年
替雷利珠单抗注射液	2180.0	1450.0	1377.5	1.3	3.5	7.8	2944.2	5158.8	10607.7
甲磺酸阿美替尼片	176.0	176.0	100.8	17.4	1.8	10.3	3068.1	5763.4	6437.1
依达拉奉右莛醇注射液浓溶液	46.5	48.1	35.8	65.6	139.6	144.7	3051.0	6718.4	5181.6
海曲泊帕乙醇胺片	409.7	126.1	126.1	0.1	1.7	4.4	27.0	2932.8	7573.3
注射用卡瑞利珠单抗	2928.0	2928.0	2576.6	1.4	1.0	1.0	4299.5	2871.8	2608.5
甲苯磺酸尼拉帕利胶囊	200.0	200.0	152.8	6.9	0.6	1.1	1457.6	2842.2	5039.7
泽布替尼胶囊	99.0	99.0	85.0	11.1	0.4	0.8	1117.0	2154.4	4131.1
海博麦布片	6.7	6.7	6.7	0.0	17.5	44.9	0.0	1626.4	4195.5
甲磺酸伏美替尼片	571.4	118.0	95.8	0.0	0.4	8.2	0.0	1297.8	3591.0
盐酸恩沙替尼胶囊	203.7	58.8	49.1	0.5	1.3	5.4	211.3	1047.8	1974.6

三、《北京市医疗机构创新药品配备及使用模式研究》调研报告

（一）调研背景

随着医药创新的不断推进，创新药品在临床治疗中的作用日益重要。为推动创新医药高质量发展，北京市出台了一系列支持政策，如 2025 年 4 月 7 日北京市医疗保障局等九部门印发的《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2025 年）》。在此背景下，为了解北京市医疗机构创新药品配备及使用模式的现状、成效、不足，以及收集相关建议和对策，开展了本次调研。2025 年 6 月 4 日-5 日课题组召开课题启动会、两场专场调研座谈会，并对北京医院、北京大学第一医院进行了实地调研。参与调研的创新药品企业有勃林格殷格翰、恒瑞、武田、亚盛药业、礼来，诺诚健华、艾力斯、拜耳、诺华、中美华东、再鼎等 10 家企业。委属医疗机构：北京大学第一医院、北京医院、中国医学科学院肿瘤医院。市属医疗机构：北京市肿瘤医院，东直门医院，垂杨柳医院。

调研主要围绕《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2025 年）》中持续推动创新医药临床使用相关条款的执行现状、成效、不足、建议和对策。创新药企业视角下，北京市医疗机构配备创新药品的主要途径、遇到的困难和建议。医疗机构视角下，配备创新药品的主要途径、在管理层面和临床医生层面等遇到的困难、挑战和建议。

（二）创新药企业调研情况反馈

1. 医疗机构配备创新药品现状

创新药品的配备情况可分为两类：一是通过国谈准入到医保目录的新药：包括协议期内当年国谈新药、协议期内历年国谈新药、协议期内历年新增适应症的国谈药、已转入常规乙类目录管理的国谈药。二是自费创新药：涵盖医保目录外的新药，以及国谈新药自上市到国谈落地期间的自费阶段药品。

2. 通过国家医保谈判 / 竞价准入新药在医疗机构的配备现状

企业反馈，目前国谈新药在全国三级医院进院率不足 10%，同时面临仿制药品上市加快的压力，新药生命周期缩短。

3. 国谈新药进院的主要障碍

（1）医疗机构药事会召开不足：以拜耳为例，近 5 年在企业重点关注的 550

家医疗机构中，平均每年医疗机构召开药事会的场次在 320 场。上海市要求医疗机构在国谈执行后 1 个月内召开药事会，北京市要求医疗机构在国谈执行后 3 个月内召开药事会，对比可知目前医疗机构召开药事会的数量不足，导致企业国谈新药无法得到合理配备使用。在北京，首医和北医系统医疗机构基本按时召开药事会，中医系统执行不足。

（2）临床科室提起新药进院申请数量有限制：医疗机构对临床科室提起新药进院申请的数量有限制，一个科室最多可提请 2-3 个品种，有些科室可能没有提请申请名额。目前国谈新药有 570 种，企业国谈新药很难得到临床科室推荐入院的名额。

（3）政策红利期限短：国谈新药只有第一个协议期的第一年有优先入院的政策红利。第一个协议期内第二年、第二个协议期，包括新增加药品适应症则不再享有优先入院的政策待遇，若第一年不能进院，此后入院机会也比较小。

（4）受国考影响使用受限：国谈新药从协议期内谈判药品身份转入常规乙类目录管理后，在国家公立医院绩效考核中不再属于除外药品费用的范围，会影响医疗机构的药占比，医疗机构则会减少用量。

（5）DRG 付费方式约束：特别是住院患者，除去北京市明确规定的 18 个除外支付的药品，都会计入医疗机构的 DRG 费用内，医院会顾虑可能产生亏损而不用。建议名单能够尽快更新和补充。

（6）临时采购途径流程耗时且处方权受限：医疗机构里往往只有个别医生能够处方临时采购的药品，有些直接面向患者的医生没有处方权。建议对于重大疾病用药的临时采购医疗机构能够有一些绿色通道。

4. 自费创新药品进院困难

自费创新药品进院面临诸多阻碍，难以顺利进入医疗机构常备药品目录。

5. “双通道” 药店途径配备的现状和问题

“双通道” 药店途径是解决用药问题的有效途径，门诊用药较为方便，但目前存在以下问题：

（1）剂型限制：部分医疗机构出于安全性顾虑，双通道药店只允许配备口服剂型，不允许配备注射液或冷链药物。

（2）企业利润损失：对于国谈药品，医保部门要求双通道药店 0 差率，药

店会要求企业在国谈确定的医保支付标准的基础上有一定折扣,通过降低进货价来弥补自身经营成本和增加利润,因此企业会再损失一部分利润。

(3) 配备渠道单一化: 实际执行中,医疗机构有倾向性地将部分药品列入“双通道”药店途径配备,以避免一些考核指标约束。一般情况下,通过“双通道”药店途径配备的药品,则不会考虑列入院内常备药品目录,双通道实际变成单通道。

(4) 使用数量有限: 双通道药品使用数量比较有限,相比于院内常备药品的配备途径,使用数量只有 1/10 左右。

(5) 商业保险报销不认可: 商业保险在报销时只认可医疗机构的发票,不认可药店的发票。

(6) 患者取药便捷性不足: 双通道药店目前数量有限,患者需要步行很远的距离,尤其是多院区的医疗机构只有一个双通道药店,患者跨院区取药距离会在 10 公里以上;冷链的药品患者取药和携带都很不方便;患者观念里认为医疗机构取药比药店取药正规,会有质疑。

(7) 配备范围待拓宽: 目前双通道配备药品的范围是针对国谈新药,是否可以拓宽到自费状态下的药品。

6. 创新药品企业的政策建议

(1) 明确药事会召开期限: 对于国谈药品,建议政府部门明确国谈目录发布一定期限内(非执行后的一定期限),医疗机构需举行国谈药物引进的药事会。

(2) 公开入院流程和结果: 医疗机构公开创新药物入院的流程和结果。对于国谈药品,医疗机构可以对外公布药事会开启的时间、流程以及规范化的临床科室推荐流程。向社会公开国谈新药在各医疗机构的配备情况,便于患者知晓哪里可以配到对应的药物。

(3) 临床试验承担机构直接入院: 建议新药上市的临床试验承担机构可以直接入院,目前仍需要通过医疗机构药事会讨论方可入院。

(4) 明确直接入院路径: 明确“国家医保谈判药品直接纳入全市定点医疗机构药品目录,医疗机构可通过‘双通道’药店实现‘应开尽开’”的具体路径。建议政府部门在文件中明确,列入院内常备药品目录应作为主要的配备渠道,双通道作为院内无法及时配备时的补充途径,避免医疗机构基于考核指标的考量,将

双通道配备作为主要的配备渠道。同时明确国谈药品直接纳入医疗机构药品目录的具体流程，是否可以不用经过药事会，不限制临床科室的新药申请提请数量。

（5）国考指标调整：“国考”医疗服务收入占比项，同步将国谈新药剔除计算范围。同时，考虑把国谈新药的配备情况作为正向激励指标给到医疗机构，增强医疗机构配备的动力。

（6）明确创新药品定义和目录：建议政府部门明确创新药品定义和制定创新药品目录，以从执行时做到创新药品目录内品种一路绿灯。药监、医保、卫生相关部门对创新药的定义，药品目录尚不明确，导致支持举措无法很好落地，建议明确牵头部门，明确定义，明确支持的药品范围。如恒瑞建议，1类新药能够列入创新药品目录，亚盛药业建议，全新的化合物结构，具有全球知识产权可以进行中美双报的药物能够明确列入创新药品目录。

（7）参考其他地区经验：参考上海市出台创新药械目录，目录内药品只要临床提出用药需求就可以进院使用；参考江苏省和上海市在国谈执行前，政府平台上组织企业和医疗机构国谈新药信息沟通会议，企业有机会依托政府平台向医疗机构传递创新药的临床价值。

（8）解决自费创新药物配备问题：明确自费创新药物如何在医疗机构或双通道药店进行配备。

（三）医疗机构调研情况反馈

1. 北京市医疗机构配备创新药品的途径

（1）组织机构：二级以上医疗机构需设立药事管理与药物治疗学委员会（药事会），负责制定并动态调整本机构药品处方集和基本用药供应目录。建立药品遴选制度和遴选程序，审核本机构临床科（处）室申请的新购入药品、调整药品品种或者供应企业等事宜；决策程序要透明、合法、合规。

（2）主要配备途径：

院内常备药品目录：以北京大学第一医院为例，国家医保药品谈判目录公布后，医院会组织集中讨论一次，按照流程引进国谈新药，具体流程为药事会对谈判目录进行分类梳理，梳理结果由医务处向各临床科室征求意见，临床科室提出新药引进申请；药事会各专业组秘书对本组情况整理和医保信息补充，组织讨论会议，讨论会议上由提起新药申请的临床科室进行答辩，形成新药申请提案，并

提交至医院药事会日常委员会大会讨论，通过后正式执行。

临时采购药品目录：适用于疑难危重症，短缺药品和低价药品，创新药品上市到医院正式引进前，临床需要使用的时候；昂贵且患者较少的药品，如罕见病用药，如果列入常备药品又没有患者使用的话，就会过期了。个别情形允许先进院后审批。

列入“双通道”药店（针对国谈新药）配备：一般有几种情况，第一宽松管理方式，除院内常备药物、麻醉药品，药品不能销售的以及抗菌药物外，国家医保谈判药品，不论口服还是注射，不设范围，统一纳入到双通道配备；第二有医疗机构顾虑安全性问题，仅允许口服剂型通过双通道途径处方；在管理层面上，为了保证医疗安全，住院患者使用双通道药品，由协议药店将药品先送到药房通过质量检验后再转给患者使用。

2. 北京市医疗机构配备创新药品的现状

北京大学第一医院反馈，2016 年 - 2023 年国谈药品配备在 50% 以上的水平，创新药配备占比相对较高，主要原因是作为教学医院，科室非常全，包括传染病和儿科都非常强，用药需求确实比较多。医疗机构配备一般考量，对于国家医保谈判药品，不会 100% 引进，一般会考虑几个方面：

（1）临床需求：结核病和艾滋病专科用药不会列在常规目录中，通过双通道或者临时采购来保障用药需求；改良型新药，比如同类复方、剂型改变等，根据临床需求来约定是否引进。

（2）与集采药品冲突：评价和集采药品是否冲突，比如已有同治疗效果的抗生素列入集采了，同类国谈药就比较难以考虑。

（3）医院场地空间容量：医院场地空间的容量也是配备时需要考虑的因素。

3. 北京市医疗机构配备创新药品的考虑、障碍及困难

（1）医疗安全和风险的顾虑：国谈新药从上市到进入医保目录时间短，在安全性，有效性方面缺少临床使用数据，其是否比院内在用的药物有优势，对于用药风险管理有顾虑。既往有在全球 63 个国家上市的药品，在临床应用中发现肌苷酸值特别高，肝损伤特别严重，因此撤市了。对于全球新的药物，二期临床和三期临床只面向一小部分受试者，临床使用还是应该持谨慎的态度，大规模使用前先做一定例数的多中心真实世界研究，进行临床监测说明药品安全性有效性，

同时没有风险质量可靠，再让医疗机构放心的推开来使用。同时，对于附条件审批的药品，要看附加条件中哪些和患者风险或用药风险相关，企业是否已经回答了这些问题，如果没有，更加应该谨慎使用；对于临床来讲，引进新药，治疗作用相同的，需要评价新药的安全性有效性是否比老药好，老药有使用经验，风险点和管控点都比较清晰。

（2）影响医疗机构国考成绩、运营绩效及医院高质量发展：

国家组织药品集中采购中标药品使用考核和配备创新药品之间的冲突：在国考中，国谈药物配备没有指标任务，集采药物有指标任务且必须完成。医疗机构每年对于同种疾病治疗所需药物数量基本相当的情况下，引入和采购新药可能会导致老药的集采任务量无法完成，考核不合格。同时，医保局招标采购部门在每一批次国家组织药品集中采购执行后，会动态监测医疗机构针对国采同类品种的使用情况，通过制定可替代药物名单来实现监测，意在提示医疗机构应多采购集采中选品种，减少采购可替代药物，此时，很可能将创新药列为集采药品的可替代药物。创新药物医保谈判由国家医保局医药服务司负责，两个司间政策有明显冲突。

国家基本药物配备及使用占比考核与创新药品配备之间的冲突：国考中针对基本药物的考核具体分 3 个方面，门诊患者基本药物处方占比、住院患者基本药物使用率、基本药物采购品种数占比。统计基本药物占总配备品种数的比例，含基本药物的处方量占总处方量的比例，考核要求为三级公立医院配备基本药物品种比例不低于 30%，采购金额占比不低于 25%，同时指标导向为逐步提高。基本药物运营指标，控制指标能否激励和优化。

门诊 / 住院次均药品费用增幅考核与创新药物配备的冲突：该指标考核的导向是逐年降低。新 32 条中写 I 类新药不计入自费率考核。目前协议期内国谈药品费用可以不计入考核，但转为常规乙类管理的国谈药品则需要列入考核范围。自费的创新药品，包括国谈新药从上市到谈判结果执行的自费阶段都会列入考核，医疗机构只能通过外购渠道满足患者需求。

影响 DRG 病组费用，影响医院绩效：按照目前政策规定，仅有奥拉帕利片等 18 个药品在 DRG 中做除外支付。同时需满足“使用除外支付名单中新药新技术的病例满足病例总费用是其所在 DRG 组次均费用的 2 倍（不含）以上，

且新药新技术费用占其病例总费用比例在 64%（不含）以上的，进行除外支付”情形。目前总计有 568 个药品通过国家医保谈判 / 竞价的途径进入到国家医保目录中，很难真正缓解医疗机构在 DRGs 付费情况下药品的成本压力。

占用医疗机构医保基金总额：导致医疗机构在医保基金总额上有超支风险。

（3）医疗机构通过“双通道”药店途径配备创新药品的情况和顾虑：

政策梳理：“双通道”是指通过定点医疗机构和定点零售药店两个渠道，满足国家医保谈判药品供应保障、临床使用等方面的合理需求，并对纳入“双通道”管理的药品，在定点医疗机构和定点零售药店施行统一的支付政策。2023 年 9 月 26 日，北京市医疗保障局出台关于进一步做好国家医保谈判药品落地试点工作的通知，选取 23 家门诊量大、国谈药采购数量少的定点医疗机构开展“双通道”管理试点工作，由北京市医保经办机构组织医疗机构，确定的 1 家定点零售药店（简称协议药店），签订三方协议。配套政策对参保人员门诊和住院就医时在协议药店购药的费用支付、结算等方面做出了规定。

现状和实操路径：北京医院是首批试点医院，执行时分为两种情况，第一种为药品进院了，但开具处方时医院没有库存，患者就到签约的双通道协议药店取药，若恰好此时协议药店也没有库存，需要在 48 小时内配齐。门诊患者持处方和医保卡到协议药店购药，并在协议药店结算，支付个人负担部分，统筹报销部分有医保经办机构结算给协议药店，用药指导由协议药店的执业药师完成；住院患者用药由协议药店配送至医院住院药房，医院接收后按医嘱给患者用药。北京医院目前双通道药店配备数量大概是 83 种，品规数量有 103 个，2024 年总共有 3746 张双通道处方，金额 600 多万。北京医院尽量在院内配备和处方，列入双通道范围的品种以患者群体少，价格偏高的药品。

困难和建议：

医保支付环节政策差异：目前政策对城镇职工比较友好，当北京市城乡居民参保的患者在协议药店购药时，需要在协议药店全额垫付结算，再持处方和购药发票到医院住院结算科，计入到当次住院费用中，出院时按住院费用在医院持医保卡报销。在这样的流程之下，城乡居民在双通道药店购药费用会占用医院总额，同时会计入住院次均费用考核。对于异地就医患者，是否能取得报销取决于参保地报销政策；对于公费医疗患者，发票是药店开具的，能否报销由单位决定；对

于商业保险患者，药店开具的发票，很可能会无法报销。

取药便捷性问题：双通道协议药店距离通常在 1 公里或者更远，患者必须本人持卡过去，取药不太方便。针对多院区医疗机构只有 1 个双通道药店，其他院区患者无法通过双通道途径拿药。

医疗风险控制：药品安全问题，不良反应的风险监测。协议药店药师审方能力比较弱，需要医疗机构药师给予指导，用药交待不到位会增加患者的用药风险，冷链配送要求全程监控，增加了这个环节就增加了风险。

信息维护问题：协议药店信息维护不及时如没有及时更改药品医保代码，则医疗机构就无法开具处方，导致患者投诉至 12345，医疗机构需要去做解释。

成本与折扣问题：协议药店经营双通道药品存在采购、库存、冷链等成本，因此常要求企业在国谈支付标准基础上给予折扣以弥补亏损。若企业与药店无法就折扣达成共识，可能导致药品无法及时配备，影响患者用药可及性。

医院管理难度：在双通道政策下，临床医生开具双通道药品处方通常不受限制，但部分处方可能缺乏合理性，存在超适应症用药、重复用药等医疗风险。医疗机构需花费额外精力进行处方审核和用药监控，增加了管理成本和工作负担。

厂牌决定权与监管缺失：国谈药品仿制上市后，同品规可能存在多个生产厂家。目前对于临床医生给患者处方的厂牌决定权尚未明确，缺乏相应的监管机制，可能导致处方随意性较大，影响药品使用的规范性和安全性。

4. 医疗机构做临时采购的考量

（1）临时采购流程与现状

院内设有明确的临时采购流程，需填写临时采购申请书，经科室负责人、医务处审批及药事会常务委员会审议，采取“一病例一议”方式满足临床需求。该流程设计旨在确保采购合规性，避免灰色交易，但也导致流程耗时较长。

（2）主要障碍

审批流程繁琐与审计压力：临时采购需接受审计和纪检监察，医疗机构需对罕见病用药等临时采购药品的年采购数量和金额逐一说明理由，增加了管理成本和行政负担。

患者自费成本压力：当创新药品或其适应症不在医保报销范围内时，患者需全额自费。若药品价格昂贵，许多患者可能因经济压力放弃购买，导致临床需求

无法满足。

真实世界证据不足与医疗风险：部分创新药品通过加速审批上市，上市初期缺乏足够的真实世界证据，医生使用时面临药物不良反应等医疗风险，可能导致临床使用积极性不高。

5. 其他方面的困难与建议

（1）医院药物管理成本压力

空间与运营成本：在药品 0 差率政策下，医院承担着采购、库存、冷链运输、设备维护等多项成本。例如，冷藏药品的冷链管理需要专业设备和人力，自动发药机等硬件投入也增加了医院的经济负担。

人员与管理成本：药师人力成本、信息系统建设成本及药品破损损耗等费用较高。尽管设有药师门诊（收费 30 元，患者自费 10 元），但实际门诊量极少，药学部门收支差距悬殊，制约了药物配备的规模和积极性。

（2）创新药品真实世界研究的资金支持

目前国家对药品上市后研究投入不足，而北京市政策中提及的“对开展真实世界研究的医疗机构给予资金支持”尚未明确落实细则。医疗机构建议设立纵向课题，专项用于评价国谈药品的真实世界效果，为临床配备提供科学依据。

（3）药物经济学评价体系的应用

建议企业通过药物经济学评价，明确创新药物使用对医院整体药费和治疗成本的影响，证明创新药的使用能够降低患者并发症发生率、缩短住院时间等，从而为医院控制总体医疗成本带来益处，增强医疗机构配备创新药的动力。

（4）临时采购与绿色通道的政策支持

尽管政策提及临时采购和绿色通道，但缺乏明确的制度规范。绿色通道进院的药品仍面临审计和纪检监察压力，导致医疗机构在执行时较为谨慎。建议进一步细化政策，明确绿色通道的适用范围、审批流程及审计豁免条件等。

（5）创新药品定义模糊的问题

政策执行困境：2024 年政府工作报告及相关文件提出鼓励创新药发展，但目前各部门对创新药品的定义尚未统一。医保部门认为国谈准入药品属于创新药，而药监部门以注册分类定义（如化学药品 1 类为全球新创新药），导致医疗机构在执行政策时缺乏明确依据。

典型案例矛盾：如老抗生素与输液组合的双室袋、国外已上市 30 年但国内按 5.1 类注册的硝酸甘油注射液等，难以界定是否属于创新药，影响了支持政策的落地效果。

（四）调研结论与建议

1. 主要结论

（1）政策执行现状与成效

北京市通过“双通道”管理、DRG 除外支付、快速挂网等政策，在一定程度上推动了创新药品的临床配备。例如，“双通道”药店为门诊患者提供了便捷的用药渠道，部分医疗机构通过优化药事会流程提高了国谈新药的进院效率。

（2）核心障碍与不足

政策协同不足：国考指标（如集采完成率、基本药物占比）与创新药配备存在冲突，DRG 付费除外名单更新滞后，导致医疗机构配备动力不足。

进院流程繁琐：药事会召开频率不足、临床科室申请名额限制、临时采购流程耗时等问题，阻碍了创新药及时进入医疗机构。

“双通道”机制待完善：存在剂型限制、企业利润压缩、患者取药不便、商业保险报销不认可等问题，实际使用效率低于院内配备。

创新药定义模糊：各部门对创新药的界定不统一，导致支持政策难以精准落地，影响了企业和医疗机构的执行积极性。

2. 系统性建议

（1）政策优化与协同层面

国考指标调整：将协议期内国谈新药剔除“药占比”“医疗服务收入占比”等考核指标，同时将创新药配备率纳入国考正向激励指标，与财政拨款和医院评级挂钩。

DRG 除外名单动态更新：建立季度更新机制，将临床价值高、费用占比大的创新药及时纳入 DRG 除外支付范围，放宽“病例总费用 2 倍以上”的限制条件。

统一创新药定义与目录：由北京市卫健委牵头，联合药监、医保部门制定《北京市创新药品目录》，明确以药品注册分类（如化学药 1 类、生物药 1 类）及全球知识产权为核心标准，定期公布目录并实行动态管理。

（2）入院流程简化层面

药事会机制改革：强制要求医疗机构在国谈目录发布后 1 个月内召开专项药事会，允许临床科室每年提交不超过 5 个创新药申请，取消“以替换方式引进新药”的限制。

临床试验机构直接入院通道：允许新药上市的临床试验承担机构凭伦理批件和临床试验数据，直接申请纳入医疗机构临时采购目录，后续再补报药事会审批。

临时采购绿色通道：对罕见病用药、重大疾病急救用药，实行“临床主任签字 + 24 小时快速审批”机制，免于常规审计（仅进行合规性抽查）。

（3）“双通道”机制完善层面

拓宽配备范围与剂型：将自费创新药纳入“双通道”管理，允许注射液、冷链药物通过双通道配备，由医疗机构药师远程指导药店进行药品验收和用药交代。

优化医保支付与报销：统一城乡居民和城镇职工在双通道药店的支付政策，允许商业保险认可药店发票，推动异地就医患者在京购药费用直接结算。

提升患者取药便捷性：要求多院区医疗机构在各院区 3 公里范围内至少设立 1 家双通道药店，支持药店提供免费冷链配送服务，患者可通过医院 APP 查询附近药店库存。

（4）激励与保障机制层面

真实世界研究专项基金：由北京市医保局设立每年 5000 万元专项基金，支持医疗机构开展创新药真实世界研究，研究成果可作为药品进院和医保续约的依据。

企业与医院成本共担：对通过“双通道”配备的药品，由医保基金承担药店运营成本的 30%，企业给予药店的折扣幅度不得超过国谈支付标准的 5%，避免过度压缩企业利润。

药学服务收费改革：将药师门诊收费标准提高至 100-200 元 / 次，医保基金报销 70%，鼓励医疗机构加强药学服务，提升创新药合理使用水平。

（5）监管与信息透明层面

创新药配备信息公开：建立北京市创新药配备信息平台，实时公布各医疗机构国谈新药进院率、“双通道”药店库存情况，方便患者查询和社会监督。

处方审核与风险监控：开发智能审核系统，对双通道药品处方进行实时监控，

重点筛查超适应症、重复用药等风险，药师可远程干预不合理处方。

部门协同监管机制：由北京市医改办牵头，建立医保、药监、卫健部门季度联席会制度，及时协调解决创新药配备中的政策冲突问题，确保各项措施落地见效。